

U-NET for Metal Artifact Reduction in Computed Tomography

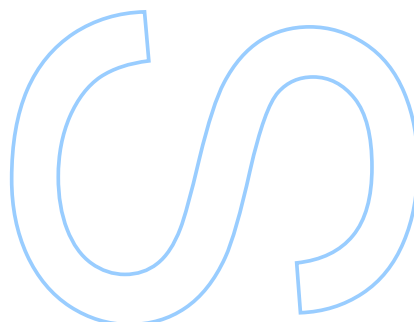
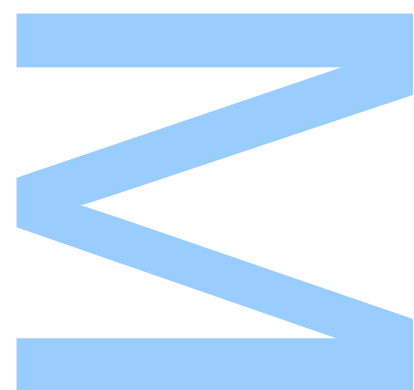
Ludmila Montorsi Queiroz

Mestrado em Física Médica

Departamento de Física e Astronomia

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

2026



UNIVERSIDADE DO PORTO

MASTERS THESIS

U-NET for Metal Artifact Reduction in Computed Tomography

Author:

Ludmila MONTORSI QUEIROZ

Supervisor:

Hélder Filipe PINTO DE OLIVEIRA

Co-supervisor:

Eduardo MATOS RODRIGUES

*A thesis submitted in fulfilment of the requirements
for the degree of MSc. Medical Physics*

at the

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
Departamento de Ciência de Computadores
Departamento de Física e Astronomia
INESC TEC

10 de maio de 2026

"The Universe is under no obligation to make sense to you."

Neil deGrasse Tyson, *Astrophysics for People in a Hurry* (2017)

"Nothing in life is to be feared; it is only to be understood."

Marie Curie, *Madame Curie: A Biography* (1937)

Acknowledgements

I would like to express my deepest gratitude to my supervisor, Helder Filipe Pinto de Oliveira, for his invaluable guidance, support, and encouragement throughout this research journey. His expertise and insights have been instrumental in shaping this thesis. I am also grateful to my co-supervisor, Eduardo Matos Rodrigues, for his constructive feedback and encouragement, which have greatly contributed to the development of this work.

UNIVERSIDADE DO PORTO

Abstract

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Departamento de Ciência de Computadores

Departamento de Física e Astronomia

INESC TEC

MSc. Medical Physics

U-NET for Metal Artifact Reduction in Computed Tomography

by [Ludmila MONTORSI QUEIROZ](#)

This thesis addresses deep learning approaches for metal artifact reduction in computed tomography images, presenting a comparative study of the different techniques proposed in the literature and measuring their performance in a rigorous and reproducible manner.

Keywords: Computed Tomography, Metal Artifact Reduction, Medical Physics, Medical Imaging, Deep Learning, Artefact, Medical Diagnostics, Physics

UNIVERSIDADE DO PORTO

Resumo

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Departamento de Ciência de Computadores

Departamento de Física e Astronomia

INESC TEC

MSc. Medical Physics

U-NET para Redução de Artefatos de Metal em Tomografia Computadorizada

por [Ludmila MONTORSI QUEIROZ](#)

Esta tese aborda abordagens de aprendizado profundo para a redução de artefatos de metal em imagens de tomografia computadorizada, apresentando um estudo comparativo das diferentes técnicas propostas na literatura e avaliando seu desempenho de maneira rigorosa e reprodutível.

Palavras-chave: Tomografia Computadorizada, Redução de Artefatos de Metal, Física Médica, Imagem Médica, Aprendizado Profundo, Artefato, Diagnóstico Médico, Física

Índice

Acknowledgements	ii
Abstract	iii
Resumo	iv
Índice	v
Lista de Figuras	viii
Lista de Gráficos	ix
Lista de Tabelas	x
Lista de Abreviaturas	xi
1 Introdução	1
1.1 Objetivo Geral	3
1.2 Objetivos Específicos	3
2 Trabalhos Relacionados	5
2.1 Métodos Tradicionais de Redução de Artefatos em CT	5
2.2 Deep Learning para Redução de Artefatos em CT	6
2.2.1 Abordagens no Domínio da Imagem	6
2.2.2 Abordagens no Domínio do Sinograma e Dual-Domain	6
2.2.3 Aprendizagem Auto-Supervisionada e GANs	7
2.3 Arquiteturas Avançadas e Mecanismos de Atenção	7
2.4 Avaliação, Generalização e Aplicabilidade Clínica	8
2.5 Síntese Crítica e Motivação do Trabalho	9
3 Materiais e Métodos	10
3.1 Visão Geral da Metodologia	10
3.2 <i>Datasets</i> Utilizados	11
3.2.1 <i>Datasets</i> Principal	11
3.2.2 <i>Dataset</i> para Validação Externa	12
3.3 Estratégia de Particionamento dos Dados	12
3.3.1 Divisão Treino – Validação – Teste	12

3.3.2	Estratificação Anatômica	12
3.3.3	Estratificação por Pacientes	12
3.4	Pré-processamento dos Dados	13
3.4.1	Correspondência entre imagens CT-MAR e DeepLesion/UCLH Stroke EIT Data	13
3.4.2	Remoção do Fundo dos Exames	16
3.4.3	Normalização das Intensidades	17
3.4.4	Máscaras de Artefato	17
3.5	Arquitetura dos Modelos	18
3.5.1	Modelo Baseline	18
3.6	Estudos de ablação	20
3.6.1	Modelo <i>Baseline + Squeeze-and-Excitation (SE)</i>	20
3.7	Estudos de ablação	22
3.7.1	Modelo <i>Baseline + Atrous Spatial Pyramid Pooling (ASPP)</i>	22
3.8	Estudos de ablação	22
3.8.1	Modelo <i>Baseline + Convolutional Block Attention Module (CBAM)</i>	22
3.9	Estudos de ablação	24
3.10	Módulos Arquiteturais Avançados	24
3.10.1	Squeeze-and-Excitation (SE)	24
	Parâmetros do Bloco SE:	26
	Operações de Ponto Flutuante (FLOPs):	26
	<i>Overhead</i> Relativo:	26
3.10.2	Atrous Spatial Pyramid Pooling (ASPP)	27
3.10.3	Convolutional Block Attention Module (CBAM)	30
	Agregação Dual (Average + Max):	31
	Rede MLP Compartilhada:	32
	<i>Pooling</i> ao Longo de Canais:	32
	Convolução Espacial:	32
	Canal <i>Attention</i> - Parâmetros:	33
	Spatial <i>Attention</i> - Parâmetros:	33
	Total CBAM:	33
	FLOPs (operações):	33
3.11	Estudos de ablação	35
3.11.1	Ablação – Fase 1	35
3.11.2	Ablação – Fase 2	35
3.12	Estratégia de Treino	36
3.12.1	Treinos com Duração Curta	36
3.12.2	Treino com Duração Intermediária	37
3.12.3	Treino com Duração Prolongada	37
3.13	Funções de Perda	37
3.13.1	Perda de Reconstrução	37
3.13.2	Perda de Segmentação – Versão <i>Dual-Head</i>	38
3.13.3	Perda Total – Versão <i>Dual-Head</i>	38
3.14	Métricas	39
3.15	Protocolos de Validação	40
3.15.1	Validação Interna	40

3.15.2 Validação Externa	40
3.16 Visão Geral do Pipeline	40
3.17 Infraestrutura Computacional	41
4 Resultados	42
4.1 Correspondências CT-MAR x DeepLesion/Stroke EIT Data	42
4.2 Ablação – Fase 1	48
4.2.1 <i>Single-Head vs Dual-Head</i>	48
4.3 Ablação – Fase 2	49
4.3.1 Impacto dos Módulos de Atenção -	49
4.4 Seleção do Modelo para Treino Intermédio	50
4.5 Treino com Duração Intermediária	50
4.6 Treino com Duração Prolongada	50
4.7 Análise de Distribuições e Overfitting – Modelo Final	50
4.8 Análise Estatística Pareada – Modelo Final	51
4.9 Resumo dos Resultados	51
5 Discussion	52
6 Conclusion	53
 Bibliography	 53
 A Appendix Title Here	 60

Lista de Figuras

3.1	Arquitetura baseada em U-Net utilizada como modelo <i>baseline</i>	18
3.2	Arquitetura baseada em U-Net utilizada como modelo <i>dual-head</i>	19
4.1	Distribuição de MS-SSIM entre pares correspondentes (CT-MAR vs DL/Stroke, aprovados automaticamente). Acima: histograma com os percentis P1 e P5, mediana, média e limiar de 0.9. Abaixo: zoom do histograma para a região de maior interesse, com destaque para os pares com MS-SSIM inferior a 0.9, que foram sujeitos a revisão manual.	43
4.2	Distribuição de MS-SSIM entre pares correspondentes (CT-MAR vs DL/Stroke, aprovados automaticamente). À esquerda: histograma com os percentis P1 e P5, mediana, média e limiar de 0.9. À direita: ECDF correspondente. Os pares com MS-SSIM inferior a 0.9 foram sujeitos a revisão manual.	44
4.3	Exemplos de pares correspondentes com valores de MS-SSIM (0.7597, 0.7694 e 0.7717, respetivamente) aprovados após revisão visual humana mesmo com pontuações baixas.	45
4.4	3 pares reprovados após inspeção visual humana com valores de MS-SSIM (head_1159: 0.4573, head_369: 0.5652 e head_763: 0.6009, respetivamente). As pontuações desses pares na similaridade de cosseno foram head_1159: 0.9960, head_369: 0.9952 e head_763: 0.9951.	46
4.5	Distribuição dos valores de similaridade de cosseno para os pares inspecionados visualmente.	47
4.6	Distribuição dos valores de MS-SSIM para os pares inspecionados visualmente.	48

Lista de Gráficos

Lista de Tabelas

3.1	Configuração dos blocos SE implementados	27
3.2	Configuração do módulo ASPP implementado	30
3.3	Configuração dos blocos CBAM implementados	34
3.4	Comparação entre CBAM e SE-Net	34
4.1	Métricas quantitativas do modelo baseline em validação e teste.	48
4.2	Resultados do estudo de <i>trade-off</i> entre reconstrução e segmentação para diferentes pesos da máscara.	49

Lista de Abreviaturas

AMP Automatic Mixed Precision.

ASPP Atrous Spatial Pyramid Pooling.

BCE Binary Cross-Entropy.

BN Batch Normalization.

CBAM Convolutional Block Attention Module.

CNN Convolutional Neural Network.

CT Computed Tomography.

CT-MAR CT Metal Artifact Reduction Challenge.

DICE Dice Similarity Coefficient.

DL Deep Learning.

FBP Filtered Back Projection.

FC Fully Connected.

FCUP Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

FLOPs Floating Point Operations.

GAN Generative Adversarial Network.

GAP Global Average Pooling.

GPU Graphics Processing Unit.

HU Unidade Hounsfield.

iMAR Iterative Metal Artifact Reduction.

IR Iterative Reconstruction.

MAE Mean Absolute Error.

MAR Metal Artifact Reduction.

MBIR Model-Based Iterative Reconstruction.

MLP Multi-Layer Perceptron.

MS-SSIM Multi-Scale Structural Similarity Index Measure.

NMAR Normalized Metal Artifact Reduction.

NPY NumPy Array.

O-MAR Orthopedic Metal Artifact Reduction.

PSNR Peak Signal-to-Noise Ratio.

ReLU Rectified Linear Unit.

RMSE Root Mean Square Error.

ROI Region of Interest.

SE Squeeze-and-Excitation.

SE-Net Squeeze-and-Excitation Network.

SEMAR Single Energy Metal Artifact Reduction.

SSIM Structural Similarity Index Measure.

TCIA The Cancer Imaging Archive.

U-Net U-shaped Network.

UP Universidade do Porto.

This thesis is dedicated to my husband, for his love and support.

Capítulo 1

Introdução

Quando Wilhelm Conrad Röntgen, professor de Física da Universidade de Würzburg, na Alemanha, decidiu repetir o experimento feito por Philipp Lenard com um tubo de Crookes modificado para estudar raios catódicos, ninguém podia prever o impacto de suas descobertas na medicina. Não demorou muito para que seus experimentos apresentassem resultados surpreendentes que demonstravam que o comportamento observado não era compatível com raios catódicos, mas sim com uma espécie de raio mais penetrante e que não sofria desvios na presença de um campo magnético. Durante o manuseio das peças usadas nos seus experimentos, percebeu que o contorno dos seus ossos estava sendo estampado na tela fluorescente que utilizava.

Assim, em 22 de dezembro de 1895, convidou sua esposa, Anna Bertha, a fazer uma exposição de 15 minutos a esses raios, obtendo-se o que seria a primeira radiografia do corpo humano. Nesse mesmo ano, Röntgen publicou o artigo "On a new kind of rays"[1], no qual batiza o agente responsável como "raios-X". Já em janeiro de 1896, os jornais anunciavam em primeira página a descoberta como uma forma revolucionária de observar o interior do corpo humano sem a necessidade de incisões cirúrgicas, apontando seu potencial uso no diagnóstico médico [2].

Em fevereiro de 1896, em Massachusetts (EUA), Edwin Brant Frost produziu uma radiografia da fratura de Colles de um paciente para seu irmão, um médico local, marcando o início da incorporação dos raios-X à prática médica [3]. Assim, em menos de um ano após o anúncio da descoberta por Röntgen, os raios-X rapidamente saíram dos laboratórios e passaram a ser utilizados de forma extensiva no diagnóstico e na terapia [3]. Desde então, a técnica passou por sucessivas modernizações e diversificou-se em múltiplas modalidades e dispositivos,

consolidando-se como ferramenta indispensável na saúde moderna [4, 5].

Dessas sucessivas modernizações surgiu, em 1971, o primeiro tomógrafo computadorizado. Essa tecnologia baseia-se no princípio de atenuação dos raios-X, em que a quantidade de radiação absorvida ou dispersa pelo material relaciona-se à sua densidade [6, 7]. A tomografia computadorizada (CT) foi a primeira modalidade de imagem médica a fornecer informações quantitativas sobre a atenuação dos tecidos, algo que não era possível com a radiografia convencional [8]. Além disso, ao permitir a visualização seccional do corpo humano, a tomografia computadorizada eliminou a sobreposição de estruturas anatômicas inerente às imagens bidimensionais, possibilitando a localização precisa e a avaliação da extensão de lesões[8].

Entretanto, esses avanços trouxeram um aumento significativo da complexidade tecnológica. A aquisição de múltiplas projeções, aliada à reconstrução computacional e ao processamento digital da imagem, introduziu novas formas de degradação que eram inexistentes ou pouco relevantes na radiografia convencional. Dessa forma, a tomografia computadorizada tornou-se particularmente suscetível à presença de artefatos, os quais podem comprometer a qualidade diagnóstica e a confiabilidade clínica das imagens [8].

Diversos tipos de artefatos podem ser observados em tomografia computadorizada, incluindo ruído, endurecimento do feixe, movimento, artefatos de anel e artefatos metálicos, os quais podem obscurecer ou simular patologias [9]. As causas desses artefatos são variadas, podendo incluir desde falhas ou descalibração dos detectores, limitações estatísticas associadas a baixas contagens de fótons, até fenômenos físicos como endurecimento e dispersão do feixe, que produzem estrias escuras entre objetos de alta atenuação, como metal, osso ou meios de contraste iodados [8].

Especificamente, artefatos de estrias causados por implantes metálicos são observados em aproximadamente 21% das varreduras tomográficas, sendo considerados extremamente comuns na prática clínica [8]. A elevada atenuação ou mesmo o bloqueio total dos raios-X por esses implantes impede que a radiação alcance adequadamente os detectores, resultando em dados de projeção de baixa qualidade e comprometendo a reconstrução da imagem [10].

O aumento do uso de implantes metálicos, impulsionado pela evolução dos cuidados de saúde, intensificou as preocupações relacionadas ao impacto negativo desses artefatos na qualidade de imagem e na confiabilidade das análises diagnósticas [10]. Tradicionalmente, diversos algoritmos de redução de artefatos de metal (MAR) foram propostos, incluindo técnicas de preenchimento de imagem, preenchimento de sinogramas e métodos de reconstrução

iterativa baseada em modelo ([MBIR](#)) ou combinações dessas abordagens [11].

Embora métodos analíticos como a *Filtered Back Projection (FBP)* tenham dominado a reconstrução tomográfica por décadas devido à sua eficiência computacional e simplicidade conceitual, suas limitações tornam-se evidentes em condições clínicas não ideais, exigindo doses de radiação mais elevadas para garantir qualidade de imagem [12]. Métodos [MBIR](#) surgiram como alternativa para superar essas limitações, ao custo de maior demanda computacional e da introdução de texturas artificiais na imagem reconstruída [12].

Mais recentemente, abordagens baseadas em aprendizado profundo têm sido amplamente investigadas para a correção de artefatos em tomografia computadorizada, demonstrando desempenho superior e maior aplicabilidade clínica em comparação com métodos convencionais [13]. Em particular, redes neurais convolucionais ([CNNs](#)) têm sido propostas para a redução de artefatos metálicos, permitindo a supressão de ruído e a preservação de detalhes anatômicos e de tecidos moles [13].

1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral desta dissertação é desenvolver, avaliar e comparar de forma rigorosa um modelo baseado em *Convolutional Neural Networks (CNNs)* para detecção e redução de artefatos em imagens de Tomografia Computorizada, privilegiando a preservação anatômica, a robustez à variação de domínio e a interpretabilidade do processo de correção.

1.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos deste trabalho incluem:

- Desenvolver um *pipeline* reproduzível para treino e avaliação de modelos de redução de artefatos em [CT](#) no domínio da imagem, com separação rigorosa entre dados de treino, validação e teste.
- Desenvolver uma arquitetura *baseline* baseada em [U-Net](#) para correção de artefatos em imagens de [CT](#), garantindo reprodutibilidade experimental.
- Avaliar uma arquitetura [U-Net single-head](#) para reconstrução de imagem como referência metodológica.

- Propor e avaliar uma arquitetura *U-Net dual-head* baseada em aprendizado multi-tarefa para reconstrução de imagem e predição de artefatos, incluindo um estudo de ablação comparativo entre as duas abordagens.
- Avaliar o impacto de módulos arquiteturais avançados, incluindo *Atrous Spatial Pyramid Pooling (ASPP)*, *Squeeze-and-Excitation (SE)* e *Convolutional Block Attention Module (CBAM)*, por meio de estudos de ablation controlados.
- Definir e aplicar critérios objetivos de seleção do modelo com base em consistência entre conjuntos de validação e teste, análise de distribuições de desempenho, controlo de sobreajuste e testes estatísticos pareados.
- Avaliar o desempenho dos modelos utilizando métricas quantitativas (*PSNR*, *MS-SSIM*, *SSIM*, *BCE* e *DICE*), análise qualitativa e mapas de erro.
- Investigar a capacidade de generalização do modelo selecionado por meio de validação externa em dados independentes provenientes do *The Cancer Imaging Archive (TCIA)*.

Capítulo 2

Trabalhos Relacionados

A redução de artefatos em [Computed Tomography \(CT\)](#) constitui um problema amplamente estudado, dada a sua relevância clínica e o impacto direto na precisão diagnóstica [10]. Ao longo das últimas décadas, diversas abordagens foram propostas, evoluindo de métodos baseados em modelos físicos e reconstrução clássica para técnicas avançadas fundamentadas em [Deep Learning \(DL\)](#) [10]. Este capítulo apresenta uma revisão crítica dos trabalhos mais relevantes, contextualizando o estado da arte e identificando lacunas que motivam a abordagem proposta nesta dissertação.

2.1 Métodos Tradicionais de Redução de Artefatos em [CT](#)

Os métodos tradicionais de redução de artefatos em [CT](#) baseiam-se predominantemente em princípios físicos e matemáticos associados à formação da imagem. Barrett e Keat[14] descrevem detalhadamente a origem dos principais artefatos em [CT](#), incluindo endurecimento de feixe, *photon starvation*, dispersão e efeitos geométricos, bem como estratégias clássicas para sua mitigação.

Técnicas de reconstrução como a Retroprojeção Filtrada ([FBP](#)) foram amplamente utilizadas devido à sua eficiência computacional, porém apresentam elevada sensibilidade ao ruído e aos artefatos metálicos. Métodos mais avançados, como [Iterative Reconstruction \(IR\)](#) e [Model-Based Iterative Reconstruction \(MBIR\)](#), incorporam modelos estatísticos do sistema de aquisição e do ruído, permitindo redução parcial de artefatos. Contudo, essas abordagens frequentemente introduzem texturas artificiais e apresentam limitações em cenários clínicos complexos [12].

Revisões recentes indicam que algoritmos comerciais de *Metal Artifact Reduction (MAR)*, como *O-MAR*, *iMAR* e *SEMAR*, embora eficazes em situações específicas, dependem de parâmetros proprietários e exibem desempenho inconsistente em casos de implantes densos ou múltiplos [10, 15]. Essas limitações impulsionaram a investigação de abordagens baseadas em aprendizagem profunda.

2.2 Deep Learning para Redução de Artefatos em CT

2.2.1 Abordagens no Domínio da Imagem

As primeiras aplicações de DL para MAR concentraram-se no domínio da imagem, explorando redes convolucionais para mapear imagens degradadas para versões corrigidas. Gjestebj et al. [16] investigaram a redução de artefatos metálicos no domínio da imagem baseada em CNN e demonstraram melhorias quantitativas significativas em comparação com as técnicas convencionais.

Zhang e Yu [17] também propuseram um modelo supervisionado baseado em *Convolutional Neural Network (CNN)* para redução de artefatos metálicos em CT, obtendo ganhos consistentes em *Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR)* e *Root Mean Square Error (RMSE)*. Esses trabalhos ajudaram a consolidar o uso de redes convolucionais para MAR no domínio da imagem. Em particular, Zhang e Yu utilizaram uma CNN rasa totalmente convolucional para fusão de informação de múltiplas imagens pré-corrigidas. Os trabalhos subsequentes adotaram cada vez mais arquiteturas de codificador-decodificador, especialmente as baseadas em *U-Net*, para tarefas de correção/restauração. Redes do tipo *U-Net* e suas variantes são capazes de capturar informações contextuais globais por meio do caminho de contração, e recuperar detalhes espaciais finos por meio do caminho de expansão e *Skip Connections*[18].

Revisões sistemáticas mais recentes consolidam esses avanços, destacando que a maioria dos métodos supervisionados no domínio da imagem apresenta desempenho competitivo, especialmente quando treinados com dados pareados de alta qualidade [10, 12].

2.2.2 Abordagens no Domínio do Sinograma e Dual-Domain

Além do domínio da imagem, alguns estudos exploraram o domínio do sinograma, com métodos de interpolação linear e *Normalized Metal Artifact Reduction (NMAR)*. Essas abordagens operam diretamente nos dados de projeção e atuam diretamente na origem física dos artefatos

metálicos[19]. No entanto, o acesso aos dados de projeção brutos é frequentemente restrito em sistemas de CT comerciais, limitando a aplicabilidade de tais abordagens em ambientes clínicos [16].

Além disso, modelos híbridos têm sido propostos para aproveitar as vantagens de cada abordagem. O método proposto por Zhang e Yu [17] procura mesclar CNN no domínio de imagem e MAR clássico no domínio do sinograma. Na abordagem adotada, o refinamento inicial ocorre no domínio da imagem, mas o método completo utiliza a imagem gerada pela CNN como *prior* para substituição de regiões afetadas no sinograma. Isso caracteriza uma abordagem híbrida, mas ainda não emprega CNN nos dois domínios. Modelos mais recentes, como o DuDoNet[20], integram redes profundas em ambos os domínios, demonstrando desempenho elevado e caracterizando o que chamamos de *Dual Domain*. No entanto, esses métodos apresentam maior complexidade computacional e dependência do acesso ao sinograma bruto, o que motiva a exploração contínua de soluções robustas no domínio da imagem.

2.2.3 Aprendizagem Auto-Supervisionada e GANs

Para contornar a escassez de dados pareados anatomicamente idênticas com artefato de metal/Livre de artefato de metal, surgiram abordagens baseadas em aprendizagem auto-supervisionada. Yu et al. [21] propuseram um método capaz de reduzir artefatos metálicos sem a necessidade de imagens de referência totalmente limpas, ampliando a aplicabilidade clínica dessas técnicas.

Outros trabalhos exploraram o uso de *Generative Adversarial Network (GAN)* para MAR. Huang et al. [22] utilizaram fusão multimodal e GANs para melhorar a preservação de textura e reduzir suavização excessiva. Apesar dos bons resultados visuais, métodos baseados em GAN podem introduzir instabilidade no treino e maior risco de alucinação estrutural[23], o que levanta preocupações clínicas.

2.3 Arquiteturas Avançadas e Mecanismos de Atenção

O uso de mecanismos de atenção tem ganhado destaque em tarefas de processamento de imagem médica. Redes com módulos de atenção por canal, como o *Squeeze-and-Excitation (SE)* [24], e atenção espacial e por canal combinadas, como o *Convolutional Block Attention Module (CBAM)* [25], demonstraram melhoria na capacidade de focar regiões relevantes.

Adicionalmente, técnicas de captura de contexto multi-escala, como o *Atrous Spatial Pyramid Pooling (ASPP)* [26], permitem ampliar o campo recetivo efetivo sem aumento substancial de parâmetros. Embora esses módulos tenham sido amplamente explorados em tarefas de segmentação e visão computacional geral, sua aplicação e avaliação sistemática no contexto específico de MAR em CT ainda permanecem relativamente limitadas na literatura recente.

2.4 Avaliação, Generalização e Aplicabilidade Clínica

A avaliação de modelos de DL para CT é tipicamente realizada por meio de métricas quantitativas como PSNR, RMSE e índices baseados em similaridade estrutural. Métricas tradicionais baseadas em erro, como RMSE e PSNR, quantificam discrepâncias pixel a pixel, mas não capturam adequadamente informações estruturais relevantes para a percepção visual e interpretação clínica. Nesse contexto, Wang et al. [27] introduziram o *Structural Similarity Index Measure (SSIM)* como uma métrica perceptual que modela explicitamente luminância, contraste e estrutura. Posteriormente, o *Multi-Scale Structural Similarity Index Measure (MS-SSIM)* foi proposto para incorporar variações estruturais dependentes de escala, estendendo o SSIM para múltiplos níveis de resolução [28]. Horé e Ziou [29] demonstraram que tanto PSNR quanto SSIM apresentam limitações dependendo do tipo de distorção considerada, sugerindo que a escolha da métrica pode depender do contexto de aplicação. Dado que os artefatos metálicos se manifestam principalmente como distorções estruturais que afetam limites anatômicos e padrões de estrias de longo alcance, métricas sensíveis à preservação estrutural, como SSIM e MS-SSIM, mostram-se particularmente adequadas para avaliar o desempenho de métodos de MAR, pois consideram explicitamente componentes estruturais em diferentes escalas espaciais [27, 28].

Além disso, um desafio crítico identificado na literatura é a generalização dos modelos. Zech et al. [30] demonstraram que modelos com elevado desempenho em bases internas podem falhar significativamente quando aplicados a dados externos, evidenciando o impacto do *domain shift*. Revisões recentes reforçam a necessidade de validação externa e avaliação clínica rigorosa para garantir segurança, robustez e aplicabilidade real [31, 32].

2.5 Síntese Crítica e Motivação do Trabalho

A literatura revisada demonstra avanços significativos na redução de artefatos em CT por meio de DL, mas também evidencia lacunas persistentes: falta de padronização experimental, validação externa limitada, risco de alucinação anatômica e exploração restrita de supervisão dual e mecanismos de atenção em conjunto.

Diante desse cenário, este trabalho propõe uma abordagem supervisionada no domínio da imagem, combinando arquitetura U-Net dual-head e módulos avançados de atenção e contexto multi-escala. A estratégia experimental adotada prioriza comparação arquitetural rigorosa por meio de treinos curtos e estudos de ablação, estabelecendo bases sólidas para seleção objetiva do modelo antes de fases de treino mais prolongadas.

Capítulo 3

Materiais e Métodos

Nesse capítulo será descrito os materiais, dados, arquiteturas e procedimentos experimentais adotados neste trabalho para a detecção e redução de artefatos em imagens de [Computed Tomography \(CT\)](#). A metodologia foi concebida para garantir reprodutibilidade, rigor experimental e avaliação justa do impacto de cada componente introduzido, seguindo uma estratégia progressiva de desenvolvimento e validação dos modelos.

3.1 Visão Geral da Metodologia

A metodologia proposta baseia-se numa abordagem supervisionada no domínio da imagem e organiza-se em três etapas principais:

1. definição de um modelo baseline e realização de treinos curtos para comparação arquitetural e estudos de ablação;
2. avaliação objetiva do impacto de módulos arquiteturais avançados;
3. preparação para fases de treino intermédio e prolongado apenas após seleção fundamentada do modelo mais robusto.

Esta separação explícita entre exploração arquitetural e otimização de treino permite reduzir vieses experimentais e evita decisões baseadas em flutuações aleatórias de desempenho.

3.2 Datasets Utilizados

3.2.1 Datasets Principal

O *dataset* principal utilizado neste trabalho provém do *CT Metal Artifact Reduction Challenge (CT-MAR)* [33, 34] promovido pela *American Association of Physicists in Medicine* e consiste em 14.000 pares de treino contendo imagens de CT com artefatos metálicos simulados e suas versões originais sem artefatos. Os dados foram gerados através de um *framework* de simulação híbrida [35], que incorpora imagens clínicas publicamente disponíveis e objetos metálicos simulados com o simulador CatSim, integrado na *toolkit* de código aberto XCIST [36]. O conjunto é distribuído em duas categorias anatômicas:

- **Head:** 1.626 (11.61%) amostras derivadas da base *UCLH Stroke EIT Data* [37, 38];
- **Body:** 12.374 (88.38%) amostras derivadas da base *NIH DeepLesion Data* [39].

Onde as pastas da categoria *body* apresentavam CTs de tronco, abrangendo fatias axiais, torácica e abdominal. Os dados estão organizados em subpastas, cada uma contendo até 1.000 amostras. Foram utilizados apenas os seguintes ficheiros para treino e validação:

1. **Imagens sem metal (referência):** Ficheiros *Target* de dimensão 512×512×1 pixels;
2. **Imagens com artefatos metálicos (corrompidas):** Ficheiros *Baseline* de dimensão 512×512×1 pixels;

Todos os ficheiros de imagem (.raw) do *dataset* são apresentados em formato binário sem cabeçalho, com precisão *float32* em ordem *little endian*. As imagens já vieram convertidas de coeficientes de atenuação linear (em unidades mm^{-1}) para *Unidade Hounsfield (HU)*, utilizando o valor de normalização de 0.02 mm^{-1} para água. Não havia no conjunto de dados informações adicionais sobre a que exame cada *slice* pertencia, se eram de um mesmo paciente, ou quais regiões anatômicas específicas estavam representadas. A única informação disponível era a organização por pasta, que indicava a categoria anatômica (Head ou Body). A falta de metadados detalhados impôs a necessidade de uma abordagem de pré-processamento cuidadosa para garantir que os dados fossem adequadamente organizados e utilizados durante o treino e validação dos modelos. Dessa forma, um esforço significativo foi dedicado ao rastreio das imagens aos conjuntos de dados originais (UCLH Stroke EIT Data e NIH DeepLesion Data) para obter informações adicionais sobre os exames e pacientes, permitindo um particionamento adequado dos dados.

3.2.2 *Dataset* para Validação Externa

Para avaliação da capacidade de generalização em dados reais independentes, foi reservado um conjunto de dados externo proveniente do *The Cancer Imaging Archive (TCIA)*. Este conjunto apresenta variações em anatomia, protocolos de aquisição e características de ruído, representando um cenário realista de *domain shift*, conforme discutido na literatura.

3.3 Estratégia de Particionamento dos Dados

3.3.1 Divisão Treino – Validação – Teste

A divisão de dados adotada foi de 70% dos pares para treino, 15% para validação e 15% para teste. Esta estratégia assegura quantidade suficiente de dados para treino, mantendo subconjuntos independentes para validação e testes, garantindo uma comparação justa entre modelos.

3.3.2 Estratificação Anatômica

O particionamento dos dados também foi estratificado de acordo com a região anatômica em duas categorias principais:

- **Body**: aproximadamente 88.4% dos volumes;
- **Head**: aproximadamente 11.6% dos volumes.

A proporção relativa entre estas categorias é preservada em todos os subconjuntos, garantindo balanceamento anatômico.

3.3.3 Estratificação por Pacientes

O particionamento dos dados também foi estratificado por pacientes, garantindo que os *slices* de um mesmo paciente não fossem distribuídos entre os conjuntos de treino, validação e teste. Esta abordagem evita vazamento de informações e assegura uma avaliação mais realista da capacidade de generalização dos modelos.

3.4 Pré-processamento dos Dados

3.4.1 Correspondência entre imagens CT-MAR e DeepLesion/UCLH Stroke EIT Data

Dado que os dados do CT-MAR *dataset* não continham metadados clínicos detalhados, foi necessário realizar um rastreo algorítmico dos *slices* até aos conjuntos de dados originais (UCLH Stroke EIT e NIH DeepLesion Data) para tornar possível a associação dos metadados fornecidos aos *slices* do CT-MAR. Este processo permitiu identificar a qual exame e paciente do DeepLesion/UCLH Stroke EIT cada imagem CT-MAR pertencia. Essas informações foram posteriormente utilizadas para realizar o particionamento dos dados em treino, validação e teste ao nível do paciente, reduzindo o risco de *data leakage* entre conjuntos experimentais.

A correta separação dos dados é particularmente importante em estudos de imagem médica baseados em *deep learning*, uma vez que *slices* pertencentes ao mesmo exame frequentemente apresentam elevada similaridade anatómica. Dessa forma, a presença simultânea de imagens do mesmo paciente em treino e teste pode inflacionar artificialmente o desempenho do modelo e comprometer a avaliação da sua capacidade de generalização [40].

As imagens do dataset DeepLesion [39] encontram-se armazenadas em formato PNG de 16 bits, enquanto as imagens do CT-MAR são disponibilizadas em formato .raw diretamente em unidades de Hounsfield (HU). Já o UCLH Stroke EIT [37] disponibiliza os exames em formato DICOM. Assim, independentemente do formato original, todas as imagens foram convertidas para HU antes da comparação, garantindo uniformidade entre os diferentes conjuntos de dados.

Após a conversão, todas as imagens foram representadas numa mesma escala de intensidade para permitir comparação direta.

O algoritmo utilizado baseia-se no facto de que imagens CT preservam informação quantitativa em unidades de Hounsfield (HU), refletindo diretamente as propriedades de atenuação dos diferentes tecidos. Como as estruturas anatómicas apresentam elevada continuidade espacial entre *slices* consecutivos de uma mesma aquisição, imagens correspondentes à mesma fatia anatómica tendem a apresentar distribuições semelhantes de HU e padrões estruturais globais altamente consistentes [27, 41].

Dessa forma, o método não procura verificar igualdade absoluta pixel-a-pixel entre imagens, mas sim determinar se a organização estrutural global da anatomia permanece extremamente semelhante entre diferentes representações da mesma fatia. Esse comportamento

é particularmente importante porque pequenas variações locais de intensidade, discretização numérica e transformações lineares associadas à conversão entre formatos de armazenamento tendem a preservar a estrutura anatômica global da imagem mesmo quando ocorrem pequenas variações locais de intensidade [27, 41].

Assim, a metodologia adotada procura identificar correspondências entre imagens com base na similaridade estrutural global, permitindo uma margem de variação local que não comprometa a identificação correta do exame e paciente de origem. Inicialmente, cada imagem foi reduzida para uma representação compacta através de *downsampling*, preservando principalmente a informação anatômica global relevante. Essa etapa reduz significativamente o custo computacional sem comprometer a estrutura geral da imagem.

Em seguida, foi calculado um vetor representativo (*fingerprint*) para cada imagem. Os *fingerprints* das imagens CT-MAR foram então comparados com os *fingerprints* das imagens DeepLesion e UCLH Stroke EIT através de uma métrica de similaridade vetorial baseada em produto escalar normalizado (similaridade de cosseno), escolhida por ser invariante a diferenças de escala global entre os vetores — propriedade relevante dado que as imagens provêm de formatos distintos com diferentes normalizações de intensidade. Para cada imagem CT-MAR, foi selecionada a imagem com maior score de similaridade.

Como a maior parte das imagens do CT-MAR teve origem no DeepLesion, o processo de rastreio foi inicialmente priorizado nesse dataset. Posteriormente, a mesma metodologia foi aplicada aos exames DICOM do UCLH Stroke EIT para identificação das imagens restantes. Dessa forma, foi possível implementar uma estratégia unificada de rastreabilidade independentemente do formato de armazenamento dos datasets de origem.

As correspondências foram consideradas válidas apenas quando o score de similaridade excedia um limiar previamente definido empiricamente. Casos com scores muito elevados foram automaticamente marcados como correspondências seguras, pois observou-se que todos os pares analisados visualmente com pontuação superior a 0.993 correspondiam efetivamente à mesma imagem. Para manter uma margem adicional de segurança, a correspondência foi considerada automaticamente válida apenas quando a pontuação excedia 0.994.

Pontuações inferiores a esse limiar indicavam correspondências potencialmente ambíguas e eram submetidas à inspeção visual manual. Já pontuações inferiores a aproximadamente 0.98 indicavam correspondências claramente incorretas e eram automaticamente descartadas sem necessidade de revisão manual. Dessa forma, todos os pares que apresentavam pontuações entre 0.98 e 0.994 foram analisados visualmente para confirmação da validade da

correspondência.

Embora a representação compacta baseada exclusivamente na média de intensidades dos blocos (HU) seja eficiente, ela pode, em teoria, gerar falsos positivos quando exames de pacientes diferentes são adquiridos com protocolos de aquisição idênticos ou apresentam estruturas anatómicas muito semelhantes, uma vez que essas condições tendem a produzir distribuições de intensidade similares e, conseqüentemente, *fingerprints* com pontuação elevada. Para mitigar esse risco, adotou-se um limiar de aceitação automática conservador (0,994) e a validação visual sistemática de todos os pares com scores entre 0,98 e 0,994. Adicionalmente, como salvaguarda complementar, todos os *matches* automáticos foram analisados em termos de MS-SSIM, onde os pares com pontuações mais críticas foram submetidos a uma revisão visual adicional para garantir a confiabilidade das correspondências.

Além disso, o método foi concebido para ignorar automaticamente imagens previamente verificadas como correspondências corretas, reduzindo redundâncias e acelerando reprocessamentos futuros. Devido ao elevado número de imagens presentes nos datasets, o processamento foi paralelizado e otimizado através da utilização de operações matriciais vetorizadas. Quando disponível, o algoritmo utilizou aceleração por GPU para reduzir o tempo de execução. Os *fingerprints* calculados também foram armazenados em cache para evitar recomputação desnecessária em execuções subsequentes.

A implementação dessa etapa de correspondência automática permitiu aumentar a confiabilidade do pipeline experimental, reduzindo o risco de associações incorretas entre imagens e garantindo maior consistência na construção do *dataset* utilizado para treino e avaliação dos modelos de redução de artefatos metálicos.

Embora o método utilize representações reduzidas das imagens em vez de comparação pixel-a-pixel completa, essa limitação não compromete o objetivo principal da metodologia. *Slices* consecutivos de um mesmo exame frequentemente apresentam elevada redundância espacial e podem, portanto, obter scores de similaridade muito próximos entre si. No entanto, o propósito do algoritmo não foi realizar alinhamento voxel-a-voxel rigoroso, mas sim identificar corretamente o exame e o paciente de origem de cada imagem CT-MAR. Dessa forma, mesmo eventuais ambiguidades entre *slices* adjacentes permanecem restritas ao mesmo volume anatómico e não introduzem risco relevante de *data leakage* entre treino, validação e teste.

A literatura demonstra que a qualidade dos pares utilizados em estudos supervisionados influencia diretamente o desempenho e a capacidade de generalização dos modelos de MAR

[10, 20]. Além disso, métricas estruturais de qualidade de imagem, como o [SSIM](#), têm sido amplamente utilizadas em imagem médica devido à sua maior sensibilidade à preservação estrutural [27]. Embora o método implementado não utilize diretamente [SSIM](#), a estratégia adotada procura preservar precisamente a informação estrutural global da imagem durante o processo de correspondência.

Este rastreio constituiu um importante procedimento de controlo de qualidade do dataset experimental e foi fundamental para garantir um particionamento adequado dos dados utilizados no treino, validação e teste dos modelos, assegurando que os subconjuntos fossem estratificados por paciente e evitando vazamento de informação entre conjuntos experimentais.

Nem todos os *slices* puderam ser rastreados, mas a maioria dos dados foi associada com sucesso aos exames originais. Dos 14.000 pares disponibilizados pelo [CT-MAR](#) Dataset, 11.942 foram rastreados inicialmente até ao DeepLesion e 1.623 até ao UCLH Stroke EIT, totalizando 13.565 pares com metadados associados. Na etapa de avaliação via [MS-SSIM](#), dentre todos os pares com pontuação abaixo de 0.90, apenas 3, anteriormente associados ao Deep Lesion, foram reprovados na inspeção visual.

Os pares restantes foram posteriormente analisados entre si, de forma a identificar aqueles que claramente pertenciam ao mesmo conjunto de exames, permitindo agrupamento adicional de 207 pares. Esses dados, apesar de não terem sido diretamente rastreados até aos datasets originais, foram mantidos no estudo, garantindo que todos os *slices* pertencentes ao mesmo exame permanecessem no mesmo subconjunto experimental.

Dado que uma quantidade significativa dos dados pôde ser rastreada com elevada confiabilidade, os casos restantes que não puderam ser agrupados de forma segura foram excluídos do processo de treino e validação. No total, 231 pares foram removidos por não apresentarem informação suficiente para garantir agrupamento seguro ao nível do paciente. Entre eles, os 3 pares reprovados por ser falso positivo na etapa de avaliação via [MS-SSIM](#).

Assim, dos 14.000 pares originalmente disponibilizados pelo [CT-MAR](#) Dataset, 13.769 foram incluídos neste trabalho, enquanto 231 foram excluídos para preservar a integridade do particionamento experimental e minimizar o risco de *data leakage*.

3.4.2 Remoção do Fundo dos Exames

Um subprojeto inicial foi dedicado à remoção do fundo dos exames para evitar a influencia de pixels irrelevantes na aprendizagem do modelo, pois as imagens de [CT](#) frequentemente

contêm grandes áreas de fundo que não contribuem para a tarefa de remoção de artefatos metálicos. A presença desses pixels pode introduzir ruído e dificultar a aprendizagem, especialmente em casos onde os artefatos estão localizados em regiões específicas do corpo. Para abordar esse desafio, foi implementada uma etapa de pré-processamento também baseada em [Deep Learning \(DL\)](#). Uma [U-Net-2D](#) foi treinada para segmentar o tecido corporal do fundo, gerando máscaras binárias que foram aplicadas às imagens originais para isolar as regiões de interesse. Esse modelo foi treinado utilizando 1.500 amostras do próprio [CT-MAR dataset](#), onde as máscaras de segmentação foram geradas automaticamente através de um processo de limiarização. Além disso, um refinamento manual foi feito nas máscaras obtidas para garantir a qualidade dos dados de treino e consequentemente a eficácia do modelo de segmentação. Esta etapa foi crucial para focar o modelo nas regiões relevantes, reduzindo a influência de artefatos de fundo e melhorando a qualidade das *features* extraídas durante o treino.

3.4.3 Normalização das Intensidades

As intensidades das imagens vêm expressas em [HU](#) do [dataset CT-MAR](#). Para reduzir variações extremas e focar em regiões clinicamente relevantes, foi aplicada uma janela de intensidade adequada ao contexto anatômico. Após o janelamento, os valores foram normalizados para o intervalo $[0, 1]$ e são gerados tensores [NPY](#) de dimensão 256×256 2D para cada slice.

3.4.4 Máscaras de Artefato

Foram produzidas máscaras binárias de diferenças das regiões afetadas por artefatos que foram utilizadas como sinal de supervisão adicional na arquitetura versão *Dual-Head*. Essas máscaras são utilizadas exclusivamente durante o treino, não sendo necessárias durante a inferência. A máscara binária de diferenças é definida formalmente como:

$$M_{diff}(i, j) = \begin{cases} 1; & \text{se } |I_{artifact}(i, j) - I_{clean}(i, j)| > \tau \\ 0; & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (3.1)$$

onde $I_{artifact}$ representa a imagem com artefatos, I_{clean} a imagem de referência limpa, e $\tau = 0.05$ é o limiar de diferença normalizada. Este *threshold* foi definido empiricamente para capturar regiões com diferenças perceptíveis mantendo robustez a ruído de baixa amplitude.

3.5 Arquitetura dos Modelos

3.5.1 Modelo Baseline

O modelo escolhido para ser o *baseline* inicial consiste em uma arquitetura baseada em **U-Net** [18], composta por *encoder-decoder* com conexões de atalho (*skip connections*). Li et al [42], aplicam blocos de normalização em lote (**BN**) e funções de ativação **ReLU** após cada convolução dinâmica. Esse trabalho faz algo semelhante, mas opta por utilizar convoluções padrão com *kernel* 3×3 , seguida dos blocos de **BN** e funções de ativação **ReLU**. A escolha por convoluções padrão é justificada pela simplicidade e eficiência computacional, além de manter a abordagem utilizada por Ronneberger et al [18]. Assim como Li et al [42], o *decoder* também utiliza *bilinear upsampling*. Essa arquitetura possui apenas um *output*, configurando um modelo *Single-Head*. A figura 3.1 ilustra a estrutura da arquitetura baseada em **U-Net** utilizada como modelo *baseline*.

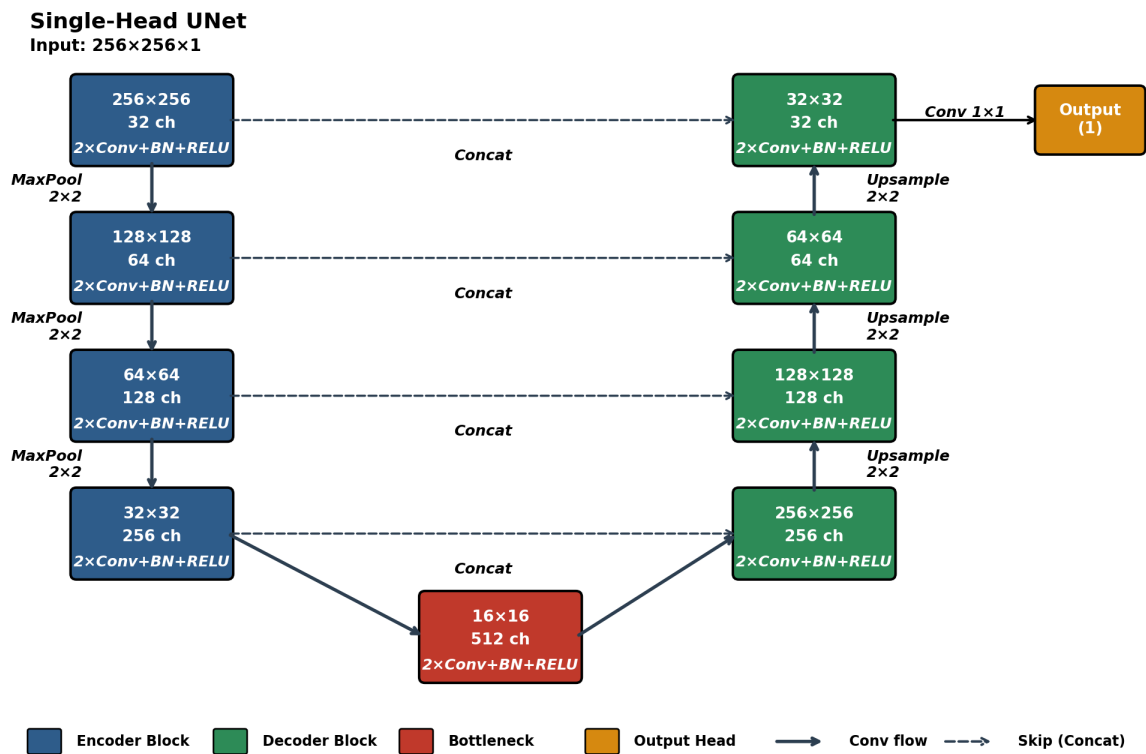


Fig.3.1 Arquitetura baseada em **U-Net** utilizada como modelo *baseline*.

Uma variação do modelo *baseline* acima descrito foi concebida, estendendo a arquitetura para uma configuração *dual-head*, onde mantêm-se o *encoder* e o *decoder* compartilhados,

mas são adicionadas duas saídas independentes na última camada do *decoder*. Cada cabeça tem tarefas distintas, sendo:

- uma cabeça dedicada à reconstrução da imagem corrigida;
- uma cabeça dedicada à predição da máscara de artefatos.

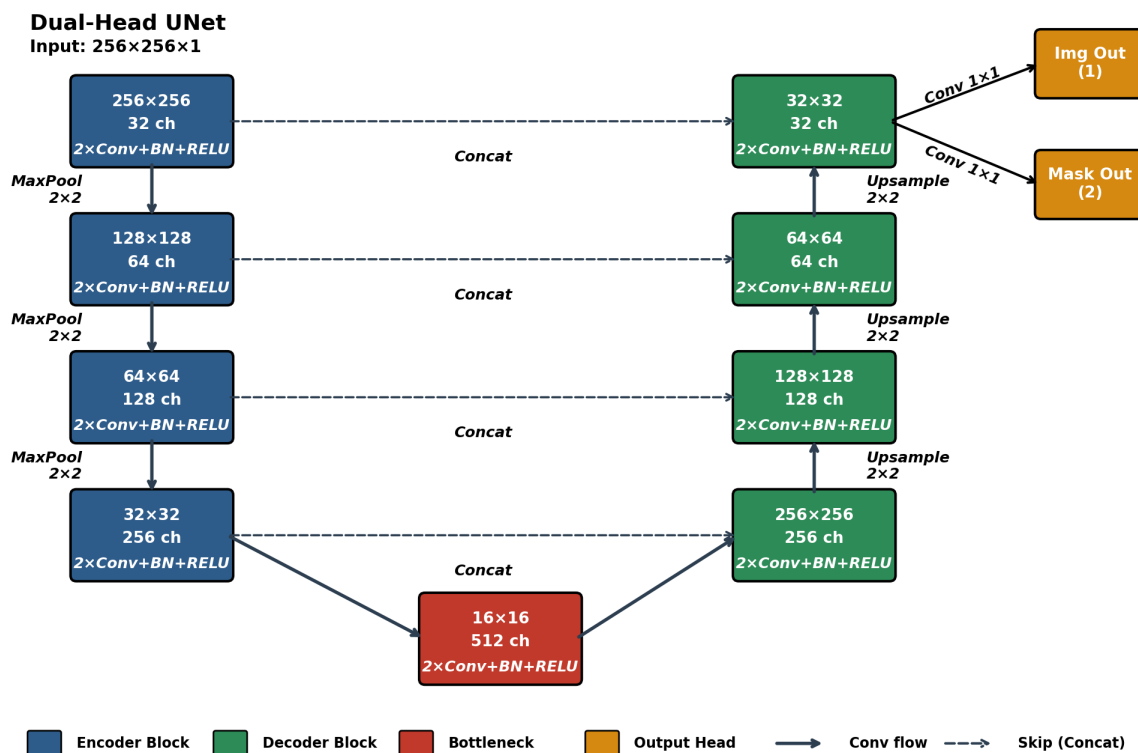


Fig.3.2 Arquitetura baseada em U-Net utilizada como modelo *dual-head*.

A figura 3.2 ilustra a estrutura da arquitetura *dual-head*. Esta configuração de supervisão dual permite que o modelo aprenda a identificar explicitamente as regiões afetadas por artefatos, fornecendo um mecanismo de controle sobre as áreas modificadas durante a reconstrução. Além disso, a cabeça de máscara pode ser utilizada para gerar mapas de atenção ou para auxiliar na interpretação dos resultados, aumentando a transparência do modelo.

3.6 Estudos de ablação

3.6.1 Modelo *Baseline* + *Squeeze-and-Excitation (SE)*

O módulo *SE* foi integrado à *U-Net* nos níveis profundos do *encoder* (enc3 e enc4), seguindo uma estratégia de recalibração de canais semânticos. Esta abordagem é motivada pela necessidade de selecionar features discriminativas em representações de alto nível, onde padrões globais como presença de artefatos metálicos e estruturas anatômicas complexas são capturados [24]. A arquitetura do *encoder* segue o fluxo:

$$\mathbf{e}'_i = \text{SE}(\mathbf{e}_i, r), \quad i \in \{3, 4\} \quad (3.2)$$

onde $\mathbf{e}_i$ representa a *feature map* após as convoluções no nível i do *encoder*, $\mathbf{e}'_i$ é a *feature map* recalibrada, e r é o *reduction ratio*. O processamento no *encoder* ocorre sequencialmente:

$$\mathbf{e}_1, \mathbf{p}_1 = \text{EncoderBlock}_{\text{baseline}}(\mathbf{x}_{\text{input}}) \quad (3.3)$$

$$\mathbf{e}_2, \mathbf{p}_2 = \text{EncoderBlock}_{\text{baseline}}(\mathbf{p}_1) \quad (3.4)$$

$$\mathbf{e}_3, \mathbf{p}_3 = \text{EncoderBlock}_{\text{SE}}(\mathbf{p}_2, r = 16) \quad (3.5)$$

$$\mathbf{e}_4, \mathbf{p}_4 = \text{EncoderBlock}_{\text{SE}}(\mathbf{p}_3, r = 16) \quad (3.6)$$

onde o bloco de *encoder* com *SE* é definido como:

$$\text{EncoderBlock}_{\text{SE}}(\mathbf{x}, r) = \begin{cases} \mathbf{e} = \text{SE}(\text{Conv- BN- ReLU}^{(2)}(\mathbf{x}), r) \\ \mathbf{p} = \text{MaxPool}(\mathbf{e}) \end{cases} \quad (3.7)$$

O *SE* é aplicado **após** as convoluções mas **antes** do *pooling*, garantindo que tanto as *skip connections* quanto os níveis subsequentes do *encoder* recebam *features* recalibradas. A integração do *SE* à rede *U-Net* tem as seguintes características:

- **Níveis Rasos do Encoder (enc1, enc2):** Mantêm arquitetura *U-Net* padrão sem mecanismos de atenção, preservando *features* geométricas de baixo nível (bordas, texturas).
- **Níveis Profundos do Encoder (enc3, enc4):** *SE* é aplicado **após** as convoluções de cada bloco, permitindo:
 - Recalibração de canais em níveis semânticos (64×64 e 32×32);
 - Supressão de canais menos informativos;

- Amplificação de *features* discriminativas para detecção de artefatos.
- **Bottleneck e Decoder:** Mantêm arquitetura padrão sem atenção, focando na eficiência computacional.
- **Skip Connections Enriquecidas:** e_3 e e_4 contêm atenção de canais, fornecendo *features* recalibradas ao *decoder*.
- **Parâmetro do SE:** *Reduction ratio* $r = 16$: Valor padrão do artigo original [24], oferecendo gargalo suficiente para generalização com *overhead* de apenas 1.4% em parâmetros.

Esta estratégia de posicionamento do SE oferece vantagens específicas para remoção de artefatos metálicos:

1. **Foco Semântico Adaptativo:** Recalibração em níveis profundos permite que o modelo aprenda dinamicamente quais canais detectam artefatos vs. anatomia normal.
2. **Contexto Global:** *Global Average Pooling* no SE captura informações da imagem completa ao calcular pesos de atenção por canal.
3. **Preservação de Detalhes:** Níveis rasos ($enc1$, $enc2$) sem atenção mantêm *features* geométricas finas intactas para reconstrução precisa.
4. **Eficiência Computacional:** Atenção apenas em níveis profundos onde a resolução espacial é menor (32×32 , 64×64) minimiza custo computacional.
5. **Melhoria nas Skip Connections:** *Features* recalibradas do *encoder* fornecem informação mais discriminativa ao *decoder*.

O módulo SE opera através de três operações sequenciais: *Squeeze* (agregação espacial via GAP), *Excitation* (rede totalmente conectada com gargalo para modelar interdependências entre canais), e *Scale* (multiplicação *element-wise* dos pesos de atenção). Esta arquitetura permite que a rede recalibre dinamicamente a importância relativa de cada canal baseando-se no conteúdo global da *feature map*.

3.7 Estudos de ablação

3.7.1 Modelo *Baseline + Atrous Spatial Pyramid Pooling (ASPP)*

O módulo **ASPP** foi integrado a **U-Net** através do *bottleneck* seguindo uma abordagem de ramos paralelos, inspirada na arquitetura *Inception* de Christian et al [?]:

$$\mathbf{z}_{bottleneck} = \mathbf{z}_{baseline} + \mathbf{z}_{ASPP} \quad (3.8)$$

onde:

- $\mathbf{z}_{baseline}$ representa o *bottleneck* padrão (2 blocos Conv- **BN**- **ReLU**)
- $\mathbf{z}_{ASPP}$ representa o módulo **ASPP** processando o mesmo tensor de entrada
- A soma *element-wise* combina ambas as representações

Esta arquitetura paralela permite que a rede aprenda tanto representações locais (via *bottleneck baseline*) quanto multi-escala (via **ASPP**), oferecendo flexibilidade durante o treinamento. Ambos os ramos processam diretamente a saída do último *encoder* ($\mathbf{e}_4$), seguindo o *design* do DeepLabv3 onde o **ASPP** opera sobre *features* originais sem transformações intermediárias.

3.8 Estudos de ablação

3.8.1 Modelo *Baseline + Convolutional Block Attention Module (CBAM)*

O módulo **CBAM** foi integrado à **U-Net** nos níveis rasos do *decoder* (dec1 e dec2), seguindo uma estratégia de refinamento espacial progressivo próximo à saída. Esta abordagem é motivada pela necessidade de atenção espacial precisa em alta resolução, onde detalhes finos e bordas de artefatos devem ser restaurados [25]. A arquitetura completa segue o fluxo:

$$\mathbf{d}'_i = \mathbf{CBAM}(\mathbf{d}_i), \quad i \in \{1, 2\} \quad (3.9)$$

onde $\mathbf{d}_i$ representa a saída do bloco de *decoder* no nível i , e $\mathbf{d}'_i$ é a *feature map* recalibrada após a aplicação do **CBAM**. O processamento no *decoder* ocorre sequencialmente:

$$\mathbf{d}_4 = \text{DecoderBlock}(\mathbf{z}_{\text{bottleneck}}, \mathbf{e}_4) \quad (3.10)$$

$$\mathbf{d}_3 = \text{DecoderBlock}(\mathbf{d}_4, \mathbf{e}_3) \quad (3.11)$$

$$\mathbf{d}_2 = \text{DecoderBlock}(\mathbf{d}_3, \mathbf{e}_2) \quad (3.12)$$

$$\mathbf{d}'_2 = \text{CBAM}(\mathbf{d}_2, r = 8, k = 7) \quad (3.13)$$

$$\mathbf{d}_1 = \text{DecoderBlock}(\mathbf{d}'_2, \mathbf{e}_1) \quad (3.14)$$

$$\mathbf{d}'_1 = \text{CBAM}(\mathbf{d}_1, r = 8, k = 7) \quad (3.15)$$

onde r é o *reduction ratio* da atenção de canais e k é o tamanho do *kernel* da atenção espacial. A integração do **CBAM** à rede **U-Net** tem as seguintes características:

- **Encoder e Bottleneck:** Mantêm arquitetura **U-Net** padrão sem mecanismos de atenção, preservando eficiência computacional nos níveis profundos.
- **Níveis Profundos do Decoder (dec4, dec3):** Operam sem atenção, focando na reconstrução inicial das *features* multi-escala.
- **Níveis Rasos do Decoder (dec2, dec1):** **CBAM** é aplicado **após** cada bloco de *decoder*, permitindo:
 - Refinamento espacial em alta resolução (128×128 e 256×256).
 - Recalibração de canais e localização espacial simultâneas.
 - Fusão com *skip connections* antes da aplicação de atenção.
- **Parâmetros do CBAM:**
 - *Reduction ratio* $r = 8$: Balanceia capacidade e eficiência na atenção de canais.
 - *Kernel size* $k = 7$: Captura contexto espacial local suficiente para transições de bordas.

Esta estratégia de posicionamento do **CBAM** oferece vantagens específicas para remoção de artefatos metálicos:

1. **Localização Precisa:** Atenção espacial em alta resolução identifica exatamente onde aplicar correções.

2. **Refinamento Progressivo:** Aplicação em dois níveis ($\text{dec2} \rightarrow \text{dec1}$) permite ajustes graduais.
3. **Preservação de *Features*:** **CBAM** atua após a fusão com *skip connections*, enriquecendo *features* já combinadas do *encoder* e *decoder*.
4. **Baixo Overhead:** Atenção apenas em níveis rasos mantém eficiência computacional (~ 1.100 parâmetros por bloco).

O módulo **CBAM** opera através de atenção sequencial: primeiro aplica atenção de canais (usando *average* e *max pooling* paralelos), seguida de atenção espacial (convolução 7×7 sobre descritores agregados por canal). Esta composição dual permite que a rede aprenda simultaneamente **quais** *features* são importantes (atenção de canais) e **onde** aplicá-las (atenção espacial).

3.9 Estudos de ablação

3.10 Módulos Arquiteturais Avançados

3.10.1 Squeeze-and-Excitation (SE)

O módulo Squeeze-and-Excitation (SE) foi proposto por Hu et al [24] como um mecanismo de atenção de canais que melhora a capacidade de representação das redes convolucionais através da modelagem explícita das interdependências entre canais. Este módulo alcançou resultados *state-of-the-art* na competição ILSVRC 2017, demonstrando sua eficácia em diversas tarefas de visão computacional.

1. Motivação e Fundamentos

Em redes convolucionais tradicionais, cada filtro opera localmente em um campo receptivo espacial, mas as relações entre diferentes canais de *features* são tratadas implicitamente através do empilhamento de camadas. O módulo **SE** introduz um mecanismo explícito de recalibração de canais, permitindo que a rede:

- **Aprenda importância relativa dos canais:** Alguns canais podem conter informações mais relevantes para a tarefa em questão.
- **Suprima canais menos informativos:** Reduz ruído e *features* irrelevantes.

- **Amplifique canais discriminativos:** Reforça *features* importantes para reconstrução de artefatos metálicos.
- **Adapte-se dinamicamente:** Pesos de atenção são calculados por instância de entrada.

O conceito fundamental é que *features* convolucionais em diferentes canais possuem importância variável para a tarefa, e essa importância pode ser modelada através de um mecanismo de atenção global.

2. Arquitetura do Bloco SE

O bloco SE opera através de três operações sequenciais: *Squeeze*, *Excitation* e *Scale*. Para um tensor de entrada $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$, o bloco SE é definido como:

$$\text{SE}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \odot \sigma(f_{\text{ex}}(f_{\text{sq}}(\mathbf{x}))) \quad (3.16)$$

onde $\odot$ denota multiplicação *element-wise* e σ é a função sigmoid.

A operação de *squeeze* agrega informações espaciais através de [Global Average Pooling \(GAP\)](#), produzindo um descritor de canal $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^C$:

$$z_c = f_{\text{sq}}(\mathbf{x}_c) = \frac{1}{H \times W} \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W x_c(i, j) \quad (3.17)$$

Esta operação resume a informação espacial de cada canal em um único valor escalar, capturando a distribuição global de respostas do canal.

A operação de *excitation* modela as interdependências entre canais através de uma rede neural totalmente conectada ([FC](#)) com gargalo:

$$\mathbf{s} = f_{\text{ex}}(\mathbf{z}, \mathbf{W}) = \sigma(\mathbf{W}_2 \cdot \text{ReLU}(\mathbf{W}_1 \cdot \mathbf{z})) \quad (3.18)$$

onde:

- $\mathbf{W}_1 \in \mathbb{R}^{\frac{C}{r} \times C}$ é a matriz de redução (primeiro [FC](#) layer)
- $\mathbf{W}_2 \in \mathbb{R}^{C \times \frac{C}{r}}$ é a matriz de expansão (segundo [FC](#) layer)
- r é o *reduction ratio*, hiperparâmetro que controla a capacidade do gargalo
- σ é a função sigmoid, garantindo que $\mathbf{s} \in [0, 1]^C$

O gargalo (*bottleneck*) com razão de redução r reduz a complexidade computacional e o número de parâmetros, enquanto impõe generalização através da limitação de capacidade. O artigo original [24] utiliza $r = 16$ como valor padrão.

A operação final (*Scale*) aplica os pesos de atenção s aos canais originais:

$$\tilde{\mathbf{x}}_c = s_c \cdot \mathbf{x}_c \quad (3.19)$$

onde $\tilde{\mathbf{x}}_c$ é o canal recalibrado e $s_c \in [0, 1]$ é o peso de atenção para o canal c .

3. Análise de Complexidade

A complexidade computacional e de parâmetros do bloco SE é significativamente menor que alternativas de atenção espacial:

Parâmetros do Bloco SE:

$$\text{\#params}_{\text{SE}} = \frac{2C^2}{r} \quad (3.20)$$

Para $C = 256$ canais e $r = 16$:

$$\text{\#params}_{\text{SE}} = \frac{2 \times 256^2}{16} = 8,192 \text{ parâmetros} \quad (3.21)$$

Operações de Ponto Flutuante (FLOPs): Para uma *feature map* de tamanho $H \times W \times C$:

$$\text{flops}_{\text{SE}} = H \times W \times C + \frac{2C^2}{r} + H \times W \times C \quad (3.22)$$

O primeiro termo corresponde ao GAP, o segundo às operações FC, e o terceiro à multiplicação *element-wise*. Note que o custo é dominado pelas operações espaciais ($H \times W \times C$), não pelas FC layers.

Overhead Relativo: Para um bloco convolucional típico com C filtros de tamanho 3×3 , que possui $9C^2$ parâmetros, o *overhead* do bloco SE é:

$$\text{Overhead} = \frac{2C^2/r}{9C^2} = \frac{2}{9r} \approx 1.4\% \text{ (para } r = 16) \quad (3.23)$$

4. Implementação e Configuração

Tabela 3.1 Configuração dos blocos SE implementados

Parâmetro	Valor
Reduction ratio (r)	16
Agregação espacial	Global Average Pooling
Primeira FC layer	$C \rightarrow C/16$
Ativação intermediária	ReLU
Segunda FC layer	$C/16 \rightarrow C$
Ativação final	Sigmoid
Aplicação	enc3, enc4 (níveis profundos)
Posicionamento	Após Conv-BN-ReLU, antes de MaxPool
Skip connections	Usam features recalibradas

5. Vantagens para Remoção de Artefatos Metálicos

A aplicação de SE nos níveis profundos do *encoder* oferece benefícios específicos para a tarefa de remoção de artefatos metálicos em CT:

- (a) **Foco Adaptativo:** O modelo aprende a priorizar canais que detectam artefatos metálicos vs. anatomia normal.
- (b) **Supressão de Ruído:** Canais que respondem a ruído são atenuados dinamicamente.
- (c) **Context-Aware:** A agregação global (GAP) permite que a rede considere o contexto completo da imagem ao recalibrar canais.
- (d) **Baixo Custo:** *Overhead* de $\sim 1.4\%$ em parâmetros garante eficiência computacional.
- (e) **Skip Connections Melhores:** *Features* recalibradas no *encoder* fornecem informação mais discriminativa ao *decoder*.

Esta implementação segue rigorosamente o design original de Hu et al [24], adaptado para arquiteturas U-Net seguindo as recomendações de Roy et al [?] para segmentação médica.

3.10.2 Atrous Spatial Pyramid Pooling (ASPP)

O módulo ASPP foi introduzido por Chen et al [26] no contexto da segmentação semântica com DeepLabv3, e posteriormente refinado pelos mesmo autores em [43] no DeepLabv3+. Este módulo é projetado para capturar informações contextuais em múltiplas escalas através de convoluções atrous (dilatadas) com diferentes taxas de dilatação, permitindo que a rede

amplie seu campo receptivo sem perda de resolução espacial ou aumento de parâmetros. Seguindo a definição de Chen et al [26], a operação de convolução *atrous* em 2D é dada por:

$$y[\mathbf{i}] = \sum_{\mathbf{k}} x[\mathbf{i} + r \cdot \mathbf{k}] w[\mathbf{k}] \quad (3.24)$$

onde $\mathbf{i}$ indexa a posição na *feature map* de saída, $\mathbf{k}$ percorre os elementos do *kernel* w , e r é a taxa de dilatação (*dilation rate*). Para $r = 1$, a operação reduz-se à convolução padrão. Valores maiores de r inserem espaços entre os elementos do *kernel*, expandindo o campo receptivo sem adicionar parâmetros.

1. Motivação e Fundamentos

Em tarefas de reconstrução de imagens médicas, a capacidade de capturar características em múltiplas escalas é crucial para:

- Detectar artefatos metálicos de tamanhos variados;
- Preservar estruturas anatômicas finas enquanto processa contexto global;
- Integrar informações locais e globais sem *downsampling* adicional.

2. Arquitetura Implementada

Nossa implementação do **ASPP** segue a arquitetura DeepLabv3+ [43], consistindo em 5 ramos paralelos que processam o mesmo tensor de entrada:

- Convolução 1×1:** Captura informações locais sem dilatação ($r = 1$)
- Convolução Separável 3×3 ($r = 3$):** Campo receptivo médio
- Convolução Separável 3×3 ($r = 6$):** Campo receptivo intermediário
- Convolução Separável 3×3 ($r = 9$):** Campo receptivo amplo
- Global Average Pooling (GAP):** Contexto global da imagem completa

Cada ramo processa a entrada de forma independente, seguindo o padrão Conv → BN → ReLU. Para garantir capacidade suficiente, cada ramo produz $F_b = \lceil F/5 \rceil$ filtros, onde F é o número de filtros desejado na saída final. Após concatenação, o tensor intermediário possui $5 \times F_b \geq F$ filtros.

3. Detalhes de Implementação

O bloco **ASPP** é definido matematicamente como:

$$\mathbf{ASPP}(\mathbf{x}) = \text{Dropout}_{0.5} \left(\text{Conv}_{1 \times 1}^F \left(\text{Concat} [\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_5] \right) \right) \quad (3.25)$$

onde cada ramo produz $F_b = \lceil F/5 \rceil$ filtros:

$$\mathbf{b}_1 = \text{Conv- BN- ReLU}(\mathbf{x}, F_b, 1 \times 1) \quad (3.26)$$

$$\mathbf{b}_2 = \text{SepConv- BN- ReLU}(\mathbf{x}, F_b, 3 \times 3, r = 3) \quad (3.27)$$

$$\mathbf{b}_3 = \text{SepConv- BN- ReLU}(\mathbf{x}, F_b, 3 \times 3, r = 6) \quad (3.28)$$

$$\mathbf{b}_4 = \text{SepConv- BN- ReLU}(\mathbf{x}, F_b, 3 \times 3, r = 9) \quad (3.29)$$

$$\mathbf{b}_5 = \text{Resize}(\text{Conv- BN- ReLU}(\mathbf{GAP}(\mathbf{x}), F_b, 1 \times 1), H \times W) \quad (3.30)$$

O ramo $\mathbf{b}_5$ captura contexto global: **GAP** agrega espacialmente $\mathbf{x}$ para $\mathbb{R}^C$, uma convolução 1×1 projeta para F_b canais, e interpolação bilinear restaura as dimensões espaciais originais $H \times W$. A concatenação dos 5 ramos resulta em $5 \times F_b$ canais. A convolução de projeção final reduz para exatamente F filtros, seguida de *dropout* com taxa de 0.5 para regularização, conforme especificado em Chen et al [43].

4. Vantagens da Implementação

As principais vantagens desta implementação incluem:

- (a) **Eficiência Computacional:** Uso de convoluções separáveis (*SeparableConv2D*) reduz o custo computacional em comparação com convoluções padrão;
- (b) **Multi-escala:** 5 ramos com taxas de dilatação $\{1, 3, 6, 9, \infty\}$ capturam *features* de diferentes escalas espaciais;
- (c) **Contexto Global:** **GAP** fornece informação da imagem completa, essencial para entender o contexto anatômico global;
- (d) **Arquitetura Paralela:** Processamento paralelo permite aprendizado conjunto de *features* locais e multi-escala;
- (e) **Regularização:** *Dropout* de 0.5 previne *overfitting* no módulo de maior capacidade;

5. Parâmetros e Configuração

Esta implementação segue rigorosamente as especificações do DeepLabv3+ [43], adaptada para o contexto de reconstrução de imagens **CT** com artefatos metálicos.

Tabela 3.2 Configuração do módulo **ASPP** implementado

Parâmetro	Valor
Número de ramos	5
Taxas de dilatação	$\{1, 3, 6, 9\} + \text{GAP}$
<i>Kernel sizes</i>	$\{1 \times 1, 3 \times 3, 3 \times 3, 3 \times 3\} + \text{GAP}$
Tipo de convolução (3×3)	Separável
Tipo de convolução (1×1)	Padrão
Normalização	BN
Ativação	ReLU
<i>Dropout</i>	0.5
<i>GAP resize method</i>	<i>Bilinear interpolation</i>

3.10.3 Convolutional Block Attention Module (CBAM)

O módulo **CBAM** foi proposto por Woo et al [25] como um mecanismo de atenção leve e efetivo que combina atenção de canais e atenção espacial de forma sequencial. Este módulo representa uma evolução natural dos blocos **SE** [24], adicionando refinamento espacial explícito para melhorar a capacidade de representação das redes convolucionais.

1. Motivação e Fundamentos

Enquanto o bloco **SE** foca exclusivamente na recalibração de canais através de agregação espacial global, o **CBAM** reconhece que diferentes regiões espaciais de um *feature map* possuem importância variável. Em tarefas de reconstrução de imagens médicas, especialmente na remoção de artefatos metálicos em **CT**, esta capacidade é crucial para:

- **Localização Espacial de Artefatos:** Identificar precisamente onde os artefatos metálicos estão localizados na imagem.
- **Refinamento de Bordas:** Preservar transições precisas entre regiões com e sem artefatos.
- **Atenção Dual:** Combinar importância de canais ("o quê") com importância espacial ("onde").
- **Supressão Seletiva:** Atenuar artefatos em locais específicos sem afetar regiões anatômicas saudáveis.

O **CBAM** é particularmente efetivo em níveis rasos do *decoder* (próximos à saída), onde a resolução espacial é alta e o refinamento de detalhes finos é essencial.

2. Arquitetura do CBAM- Atenção Sequencial

O CBAM opera através de dois módulos sequenciais: *Channel Attention* seguido de *Spatial Attention*. Para um tensor de entrada $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$, o CBAM é definido como:

$$\text{CBAM}(\mathbf{F}) = \mathbf{F}'' = M_s(\mathbf{F}') \otimes \mathbf{F}' \quad (3.31)$$

onde:

$$\mathbf{F}' = M_c(\mathbf{F}) \otimes \mathbf{F} \quad (3.32)$$

$$\mathbf{F}'' = M_s(\mathbf{F}') \otimes \mathbf{F}' \quad (3.33)$$

e $\otimes$ denota multiplicação *element-wise* (*broadcasting* quando necessário), $M_c \in \mathbb{R}^{1 \times 1 \times C}$ é o mapa de atenção de canais, e $M_s \in \mathbb{R}^{H \times W \times 1}$ é o mapa de atenção espacial.

3. Módulo de Atenção de Canais

O módulo de atenção de canais do CBAM estende o conceito do SE-Net utilizando tanto *average pooling* quanto *max pooling* para agregar informações espaciais, capturando características complementares:

$$M_c(\mathbf{F}) = \sigma(\text{MLP}(\text{AvgPool}(\mathbf{F})) + \text{MLP}(\text{MaxPool}(\mathbf{F}))) \quad (3.34)$$

onde σ é a função sigmoid e **Multi-Layer Perceptron (MLP)** denota uma rede totalmente conectada compartilhada com gargalo.

Agregação Dual (Average + Max):

$$\mathbf{f}_{\text{avg}}^c = \frac{1}{H \times W} \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W F^c(i, j) \quad (3.35)$$

$$\mathbf{f}_{\text{max}}^c = \max_{i \in [1, H], j \in [1, W]} F^c(i, j) \quad (3.36)$$

O *average pooling* captura a magnitude média de ativação, enquanto o *max pooling* captura a resposta mais forte, oferecendo representações complementares da distribuição de *features* em cada canal.

Rede MLP Compartilhada: O artigo original [25] utiliza uma MLP de duas camadas com *reduction ratio* $r = 16$ (posteriormente refinado para $r = 8$ em implementações práticas):

$$\text{MLP}(\mathbf{f}) = \mathbf{W}_1(\text{ReLU}(\mathbf{W}_0(\mathbf{f}))) \quad (3.37)$$

onde $\mathbf{W}_0 \in \mathbb{R}^{C/r \times C}$ e $\mathbf{W}_1 \in \mathbb{R}^{C \times C/r}$.

O mapa final de atenção de canais é dado por:

$$M_c = \sigma(\mathbf{W}_1(\text{ReLU}(\mathbf{W}_0(\mathbf{f}_{\text{avg}}))) + \mathbf{W}_1(\text{ReLU}(\mathbf{W}_0(\mathbf{f}_{\text{max}})))) \quad (3.38)$$

Note que os mesmos pesos $\mathbf{W}_0$ e $\mathbf{W}_1$ são compartilhados entre os dois ramos (*average* e *max*), reduzindo o número de parâmetros.

4. Módulo de Atenção Espacial

Após a recalibração de canais, o módulo de atenção espacial refina a localização das *features* importantes:

$$M_s(\mathbf{F}') = \sigma(f^{7 \times 7}([\text{AvgPool}(\mathbf{F}') + \text{MaxPool}(\mathbf{F}')])) \quad (3.39)$$

onde $[+]$ denota concatenação ao longo do eixo de canais e $f^{7 \times 7}$ representa uma convolução com *kernel* 7×7 .

Pooling ao Longo de Canais: Para capturar informações espaciais, o CBAM agrega *features* ao longo da dimensão de canais:

$$\mathbf{F}_{\text{avg}}^s(i, j) = \frac{1}{C} \sum_{c=1}^C F'^c(i, j) \quad (3.40)$$

$$\mathbf{F}_{\text{max}}^s(i, j) = \max_{c \in [1, C]} F'^c(i, j) \quad (3.41)$$

resultando em dois descritores espaciais $\mathbf{F}_{\text{avg}}^s, \mathbf{F}_{\text{max}}^s \in \mathbb{R}^{H \times W \times 1}$.

Convolução Espacial: Os dois descritores são concatenados e processados por uma convolução padrão:

$$M_s = \sigma(\mathbf{W}^{7 \times 7} * [\mathbf{F}_{\text{avg}}^s + \mathbf{F}_{\text{max}}^s]) \quad (3.42)$$

onde $\mathbf{W}^{7 \times 7} \in \mathbb{R}^{7 \times 7 \times 2 \times 1}$ é o *kernel* convolucional. O *kernel* 7×7 foi determinado empiricamente por Woo et al [25] como oferecendo o melhor compromisso entre campo receptivo e eficiência computacional.

5. Análise de Complexidade

Canal *Attention* - Parâmetros:

$$\#params_{CA} = \frac{2C^2}{r} \quad (3.43)$$

Para $C = 64$ canais (dec1) e $r = 8$:

$$\#params_{CA} = \frac{2 \times 64^2}{8} = 1,024 \text{ parâmetros} \quad (3.44)$$

Spatial *Attention* - Parâmetros: Para *kernel* 7×7 processando 2 canais (*avg* + *max*):

$$\#params_{SA} = 7 \times 7 \times 2 \times 1 = 98 \text{ parâmetros} \quad (3.45)$$

Total CBAM:

$$\#params_{CBAM} = \frac{2C^2}{r} + 2k^2 \quad (3.46)$$

Para $C = 64$, $r = 8$, $k = 7$: $1,024 + 98 = 1,122$ parâmetros (negligível comparado a uma camada convolucional 3×3 que teria $64 \times 64 \times 9 = 36,864$ parâmetros).

FLOPs (operações):

$$FLOPs_{CA} \approx 2HWC + \frac{2C^2}{r} \quad (3.47)$$

$$FLOPs_{SA} \approx 2HWC + HW \times 2k^2 \quad (3.48)$$

$$FLOPs_{CBAM} \approx 4HWC + \frac{2C^2}{r} + 2HWk^2 \quad (3.49)$$

Para $H = W = 256$, $C = 64$, $r = 8$, $k = 7$:

$$FLOPs_{CBAM} \approx 16.8M + 1K + 6.4M \approx 23.2M \text{ FLOPs} \quad (3.50)$$

6. Implementação e Configuração

Tabela 3.3 Configuração dos blocos CBAM implementados

Parâmetro	Channel Attention	Spatial Attention
Reduction ratio (r)	8	—
Kernel size (k)	—	7×7
Pooling type	Avg + Max (parallel)	Avg + Max (concat)
Pooling dimension	Espacial ($H \times W$)	Canal (C)
MLP layers	$C \rightarrow C/8 \rightarrow C$	—
Conv layers	—	$2 \rightarrow 1$ (7×7)
Ativação intermediária	ReLU	—
Ativação final	Sigmoid	Sigmoid
Aplicação	dec1, dec2 (rasos)	dec1, dec2 (rasos)
Posicionamento	Pós-decoder, sequencial	Pós-channel attention
Parâmetros (C=64)	1,024	98
Total CBAM	1,122	

7. Comparação: CBAM vs. SE-Net

Tabela 3.4 Comparação entre CBAM e SE-Net

Característica	SE-Net	CBAM
Atenção de canais	✓	✓
Atenção espacial	×	✓
Pooling types	Avg only	Avg + Max
Parâmetros (C=64, r=8)	1,024	1,122
Foco	Semântico ("o quê")	Semântico + Espacial ("onde")
Melhor aplicação	Encoder profundo	Decoder raso
Campo de atuação	Global	Global + Local

8. Vantagens para Remoção de Artefatos Metálicos

A aplicação de CBAM nos níveis rasos do *decoder* oferece benefícios específicos:

- Localização Precisa:** Atenção espacial identifica exatamente onde aplicar correções.
- Refinamento de Bordas:** *Kernel* 7×7 captura contexto local suficiente para transições suaves.
- Atenção Dual:** A atenção de canal seleciona *features* relevantes; a atenção espacial localiza onde aplicá-las.
- Supressão Adaptativa:** Artefatos são atenuados espacialmente sem afetar anatomia distante.

- (e) **Preservação de Detalhes:** Alta resolução em dec1/dec2 permite refinamento fino de texturas e estruturas.
- (f) **Baixo Overhead:** $\sim 1,100$ parâmetros por bloco ($< 3\%$ dos parâmetros de uma camada convolucional típica).

Esta implementação segue fielmente o design original de Woo et al. [25], adaptado para a arquitetura **U-Net** com posicionamento estratégico nos níveis rasos do *decoder* para maximizar o refinamento espacial na reconstrução de imagens **CT**.

3.11 Estudos de ablação

Foram avaliadas diferentes arquiteturas, seguindo uma estratégia de desenvolvimento incremental, onde cada módulo é adicionado de forma isolada para permitir avaliação objetiva do impacto de cada componente e também foi implementada uma ablação dividida por etapas.

3.11.1 Ablação – Fase 1

A primeira etapa consistiu em determinar a melhor configuração entre as versões *single-head* e *dual-head* e avaliar o impacto da supervisão adicional com máscara na qualidade da reconstrução e na capacidade de redução de artefatos. A configuração com melhores resultados será selecionada como modelo *baseline* para as etapas subsequentes de avaliação dos módulos arquiteturais avançados. As configurações avaliadas nessa primeira etapa foram:

- modelo **U-Net** com saída *single-head*;
- modelo **U-Net** com saída *dual-head*.

3.11.2 Ablação – Fase 2

A segunda etapa consistiu em avaliar o impacto de cada módulo arquitetural avançado de forma isolada, comparando cada configuração com o modelo *baseline* vencedor da etapa anterior. As configurações avaliadas foram:

- modelo *baseline* + **ASPP**;
- modelo *baseline* + **SE**;
- modelo *baseline* + **CBAM**;

- modelo *baseline* + *ASPP* + *SE* + *CBAM* (denominado *Enhanced*).

As fases 1 e 2 da ablação são realizadas usando uma estratégia de treino curto. A configuração que apresentou melhor desempenho na segunda etapa foi selecionada como modelo final para as fases subsequentes de treino intermediário e prolongado, onde serão realizados ajustes finos de hiperparâmetros e validação externa em dados independentes. Durante toda a ablação, os modelos receberam os mesmos protocolos de treino, incluindo conjunto de dados (*train*, *val* e *test*), otimizador, scheduler, taxa de aprendizagem, número de épocas e critérios de convergência, *Batch size*, funções de perda e métricas de avaliação, garantindo comparabilidade objetiva entre as arquiteturas.

3.12 Estratégia de Treino

3.12.1 Treinos com Duração Curta

Nessa fase os modelos foram treinados por um número reduzido de épocas para realização da comparação arquitetural citada seção anterior. Isso permitiu observar tendências de desempenho iniciais sem o custo computacional associado a treinos prolongados.

- **Otimização, *Scheduler* e Taxa de Aprendizagem:**

Nessa etapa, foram utilizados otimizador *ADAM* e scheduler *Reduce on Plateau*. A taxa de aprendizagem foi ajustada proporcionalmente ao progresso inicial observado nas primeiras épocas.

- **Protocolo de Convergência:**

Para garantir comparabilidade justa entre arquiteturas com diferentes capacidades e velocidades de convergência, foi definido um protocolo de convergência uniforme. O critério principal exige variação de *MS-SSIM* inferior a 0.001 entre as duas últimas épocas de validação por 3 épocas consecutivas, associada a um gap treino – validação inferior a 0.003. Esse protocolo é projetado para identificar quando o modelo atinge um platô de desempenho, evitando comparações baseadas em épocas fixas que podem favorecer arquiteturas com convergência mais rápida ou mais lenta.

3.12.2 Treino com Duração Intermediária

Após a fase de treino curto, uma arquitetura vencedora foi determinada para a etapa de treino intermediário. Onde será testado o impacto de um novo conjunto de otimizador e *scheduler*. O otimizador *AdamW* e o *scheduler Cosine Annealing* serão testados nesta fase, dada a sua capacidade de adaptação dinâmica da taxa de aprendizagem, o que pode potencialmente melhorar a convergência e o desempenho final do modelo. Nessa fase foram avaliados:

- Modelo vencedor da fase de treino curto (*Adam* + *ReduceOnPlateau*);
- Modelo vencedor da fase de treino curto (*AdamW* + *Cosine Annealing*)

A configuração que apresentar melhor desempenho nessa fase de treino intermediário será selecionada para a fase de treino prolongado, onde serão realizados ajustes finos de hiperparâmetros e validação externa em dados independentes.

3.12.3 Treino com Duração Prolongada

Essa fase tem como objetivo otimizar ao máximo o desempenho do modelo selecionado na fase de treino intermediário, realizando ajustes finos de hiperparâmetros, como taxa de aprendizagem, peso das funções de perda e regularização. Nesse modelo final, será medido o desempenho geral na redução dos artefatos metálicos com as ferramentas propostas e apresentada as estatísticas correspondentes. Além disso, será realizada validação externa em dados independentes para avaliar a capacidade de generalização do modelo em cenários realistas de *domain shift*.

3.13 Funções de Perda

3.13.1 Perda de Reconstrução

Apesar de L2 ser amplamente utilizada para restauração de imagem, Zhao et al. [44] destacam os melhores resultados de L1 ao estudar diferentes funções de perda para essa tarefa. Os autores também estudaram funções de perda baseadas em SSIM e MS-SSIM, sendo que a primeira alcança resultados igual ou levemente inferior a L1, enquanto a segunda apresenta desempenho melhor que SSIM mas ainda não supera L1 de forma clara. O trabalho também testa um mix de L1 e MS-SSIM, e obteve-se resultados superiores em todas as métricas avaliadas pelos autores. Essa combinação é justificada pela complementaridade entre as duas

funções, onde L1 favorece fidelidade local e MS-SSIM promove preservação estrutural, resultando em uma correção mais equilibrada dos artefatos. Devido a esses resultados, a função de perda de reconstrução adotada neste trabalho é a soma ponderada de L1 e MS-SSIM. Os pesos utilizados foram 0.7 para L1 e 0.3 para MS-SSIM, baseando-se na recomendação de Zhao et al. [44]. A relação adotada para a combinação das funções de perda é a seguinte:

$$\mathcal{L}_{Recon} = 0.7 \cdot \mathcal{L}_{L1} + 0.3 \cdot \mathcal{L}_{MS-SSIM}$$

[44] utiliza filtragem Gaussiana em L1 para reduzir o impacto de ruído e favorecer a correção de artefatos, mas essa abordagem pode não ser ideal para tomografias computadorizadas, onde a precisão radiométrica é crucial. Portanto, neste trabalho, optou-se por utilizar a perda L1 direta sem filtragem gaussiana, garantindo máxima fidelidade na reconstrução dos valores de Unidade Hounsfield (HU), enquanto o MS-SSIM continua a garantir a preservação estrutural em múltiplas escalas. Essa combinação de função de perda é adotada para a arquitetura *single-head* e também para a cabeça de reconstrução da arquitetura *dual-head*. Dessa forma, garante-se que a ablação entre as duas versões seja justa, isolando o impacto da supervisão adicional da máscara.

3.13.2 Perda de Segmentação – Versão *Dual-Head*

Baseado nos estudos de Isensee et al. [45], a cabeça de predição da máscara de artefatos, presente na versão *dual-head*, é treinada utilizando uma combinação de DICE Loss e Binary Cross-Entropy (BCE), que se mostrou adequada para problemas de segmentação com desequilíbrio de classes [46]. A relação adotada para a combinação das funções de perda é a seguinte:

$$\mathcal{L}_{Seg} = \mathcal{L}_{Dice} + \mathcal{L}_{BCE}$$

3.13.3 Perda Total – Versão *Dual-Head*

A função de perda total para a versão *dual-head* é composta pela ponderação das perdas de reconstrução e segmentação, e é definida como:

$$\mathcal{L} = 1.0 \cdot \mathcal{L}_{Recon} + 0.01 \cdot \mathcal{L}_{Seg}$$

3.14 Métricas

1. Monitoramento do treinamento

Durante o treinamento, as seguintes métricas foram monitoradas para avaliar o desempenho do modelo e orientar o processo de otimização:

- **Loss de Reconstrução:** Monitorada para verificar a capacidade de aprendizagem do modelo em remover artefatos (reconstruir).
- **Loss de Segmentação:** Monitorada exclusivamente para a versão *dual-head* para avaliar a capacidade de aprendizagem do modelo em identificar as regiões afetadas por artefatos (segmentar).
- **PSNR e MS-SSIM:** Monitorados para avaliar a qualidade da imagem reconstruída em termos de fidelidade e preservação estrutural.

2. Avaliação

Na fase de inferência, os modelos foram avaliados utilizando métricas quantitativas amplamente adotadas na literatura, em comparação com o *Ground Truth*. As métricas utilizadas para a avaliação global da qualidade da imagem reconstruída foram:

- **PSNR** ;
- **MS-SSIM**.

Para a análise baseada em ROI, empregamos:

- **PSNR** ;
- **SSIM**.

Wang et al. [28] descrevem **MS-SSIM** como um método de avaliação de qualidade de imagem através de cinco escalas com *downsampling* iterativo por fator 2, resultando em uma redução de resolução de até 1/16 do tamanho original. O método foi validado em bases de dados de imagens completas, sem considerar aplicação em regiões fragmentadas ou espacialmente seletivas. Devido ao *downsampling* progressivo, a aplicação **MS-SSIM** em ROIs pequenas ou fragmentadas (como a zona distante em nossa análise) resultaria na mistura de pixels de ROI e não-ROI nas escalas reduzidas, comprometendo a interpretabilidade dos resultados. Por isso, utilizou-se **SSIM** regular em vez de **MS-SSIM** nesse caso. De fato, as literaturas recentes tem demonstrado performance

estatisticamente muito melhor em fidelidade para [MS-SSIM](#) e [SSIM](#) comparado a outras métricas de avaliação de qualidade de imagem[47]. Especialmente para imagens médicas, onde a fidelidade das imagens preditas é crucial, a escolha de métricas que refletem a percepção humana de qualidade e preservação estrutural é fundamental. Portanto, [MS-SSIM](#) e [SSIM](#) foram selecionados como as principais métricas para avaliação quantitativa da qualidade das imagens reconstruídas, garantindo uma análise robusta e relevante para o contexto clínico. E o [PSNR](#) foi utilizado como métrica complementar para avaliar a fidelidade radiométrica das reconstruções, especialmente importante em tomografias computadorizadas onde a precisão dos valores de [HU](#) é essencial para diagnóstico e planejamento clínico.

3.15 Protocolos de Validação

3.15.1 Validação Interna

A validação interna foi conduzida nos conjuntos de validação e teste, avaliando consistência, estabilidade e capacidade de generalização *intra-dataset*.

3.15.2 Validação Externa

A validação externa foi realizada em dados independentes provenientes do [The Cancer Imaging Archive \(TCIA\)](#), permitindo avaliar o impacto de *domain shift* e a robustez do modelo em cenários não vistos durante o treino.

3.16 Visão Geral do Pipeline

O pipeline desenvolvido neste trabalho segue uma abordagem supervisionada no domínio da imagem e é composto pelas seguintes etapas principais:

1. aquisição e organização dos dados;
2. pré-processamento e normalização;
3. treino de modelos baseados em [U-Net](#) com diferentes configurações arquiteturais;
4. avaliação quantitativa e qualitativa;

5. validação externa em dados independentes.

O objetivo do pipeline é garantir reprodutibilidade, controlo experimental rigoroso e avaliação justa do impacto de cada componente arquitetural introduzida ao longo do estudo.

3.17 Infraestrutura Computacional

Esse trabalho foi realizado utilizando uma GPU RTX 4000 ADA e o ambiente de desenvolvimento baseou-se em Python, TensorFlow/Keras e *Visual Studio Code*. O projeto oferece suporte a precisão mista ([AMP](#)) que pode ser desativado via argumento, permitindo otimizar o uso de memória e acelerar o treino, especialmente em modelos mais complexos.

Capítulo 4

Resultados

Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados obtidos a partir dos experimentos descritos no Capítulo 3. A análise é organizada em quatro etapas progressivas: (i) validação da qualidade das correspondências automáticas entre os datasets **CT-MAR** e DeepLesion/Stroke EIT, assegurando a confiabilidade da base de dados utilizada; (ii) estudos de ablation em treinos curtos para comparação arquitetural dos módulos de atenção e contexto multi-escala; (iii) seleção objetiva do modelo candidato com base em critérios de consistência e significância estatística; e (iv) avaliação do modelo selecionado em treinos de duração intermédia e prolongada.

4.1 Correspondências **CT-MAR** x DeepLesion/Stroke EIT Data

Antes de avançar para a análise dos resultados dos modelos de redução de artefatos, foi realizada mais uma avaliação dos resultados **CT-MAR** x DeepLesion/Stroke EIT para verificar a qualidade das correspondências automáticas. Esta etapa é crucial para garantir uma camada extra de confiança nos resultados obtidos pelo algoritmo de comparação de similaridade estrutural. Todos os pares que tiveram a correspondência aprovada automaticamente pelo fato de seu score ser acima de 0.994 foram revisados por um novo algoritmo que calcula o **MS-SSIM** entre as imagens correspondentes. Um histograma da distribuição dos **MS-SSIM** foi gerado, e os pares com pontuação menor que 0.9 foram revisados manualmente sendo aprovado ou recusado com base em avaliação humana.

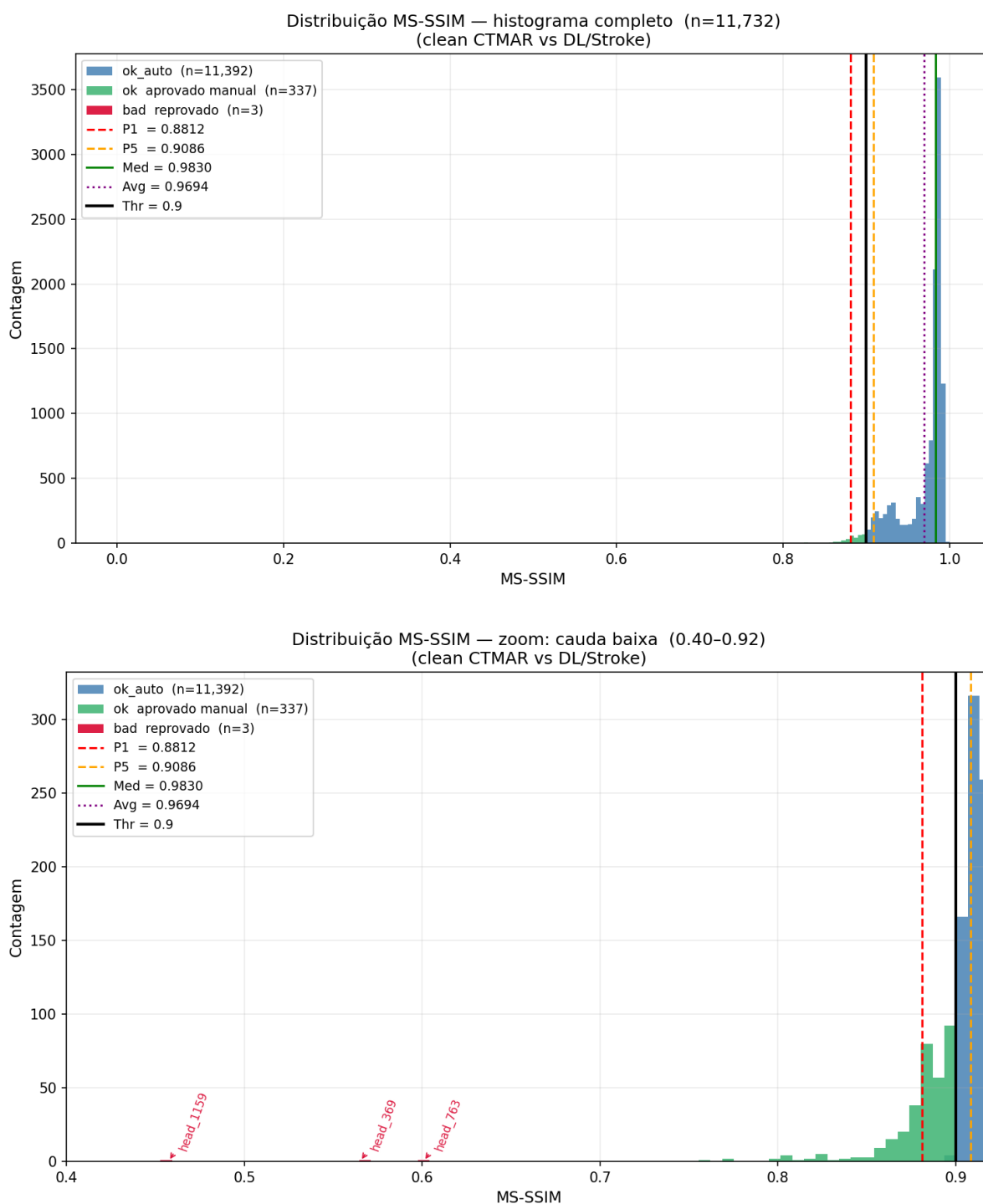


Fig.4.1 Distribuição de MS-SSIM entre pares correspondentes (CTMAR vs DL/Stroke, aprovados automaticamente). Acima: histograma com os percentis P1 e P5, mediana, média e limiar de 0.9. Abaixo: zoom do histograma para a região de maior interesse, com destaque para os pares com MS-SSIM inferior a 0.9, que foram sujeitos a revisão manual.

A análise da distribuição entre os pares correspondentes revela que a maioria dos pares apresenta alta similaridade estrutural, com um valor médio de 0.9694 e uma mediana de

0.9830, indicando que o processo de correspondência automática é, em geral, confiável e eficaz na identificação de pares correspondentes entre os datasets CT-MAR e DeepLesion/Stroke EIT.

Os pares com pontuação de MS-SSIM abaixo de 0.9 eram 340 no total, apenas 3 foram reprovados após inspeção visual humana 4.2. Nessa inspeção, percebe-se que mesmo os casos com pontuações bastante baixas de MS-SSIM não eram falsos positivos e sim devido a diferenças no pós-processamento ou tratamento geral das imagens que geram alterações locais no qual o MS-SSIM é mais sensível. Isso pode ser visualizado na figura 4.3. Esse fato evidencia a eficácia da estratégia de correspondência por similaridade estrutural global adotada, que conseguiu identificar os pares com precisão, com apenas 3 falsos positivos identificados, mesmo após análise rigorosa 4.4. Mostrando que a metodologia é robusta e teve desempenho superior em detectar slices nesse trabalho do que uso do próprio MS-SSIM. Pois, enquanto as diferenças locais afetaram o MS-SSIM de forma mais significativa, a metodologia baseada em similaridade de cosseno conseguiu identificar as correspondências corretas com pontuação global elevada, mesmo em casos de diferenças locais acentuadas.

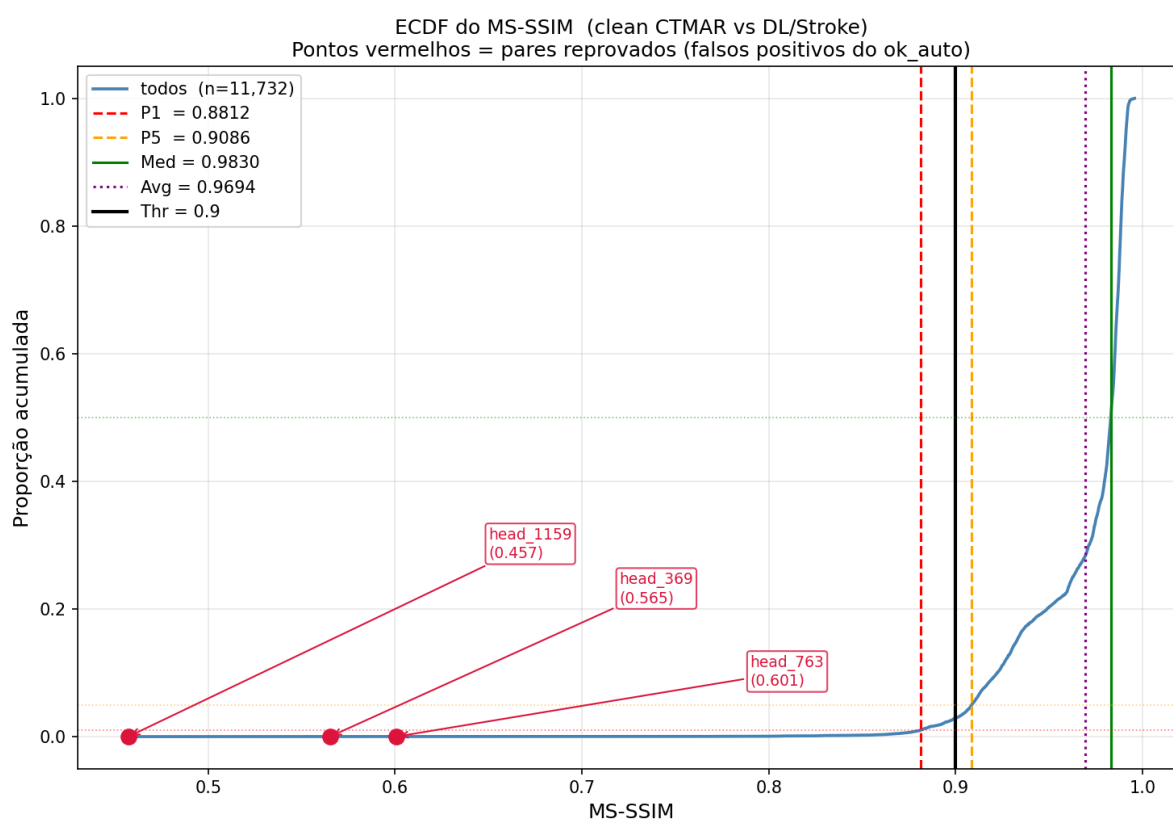


Fig.4.2 Distribuição de MS-SSIM entre pares correspondentes (CT-MAR vs DL/Stroke, aprovados automaticamente). À esquerda: histograma com os percentis P1 e P5, mediana, média e limiar de 0.9. À direita: ECDF correspondente. Os pares com MS-SSIM inferior a 0.9 foram sujeitos a revisão manual.

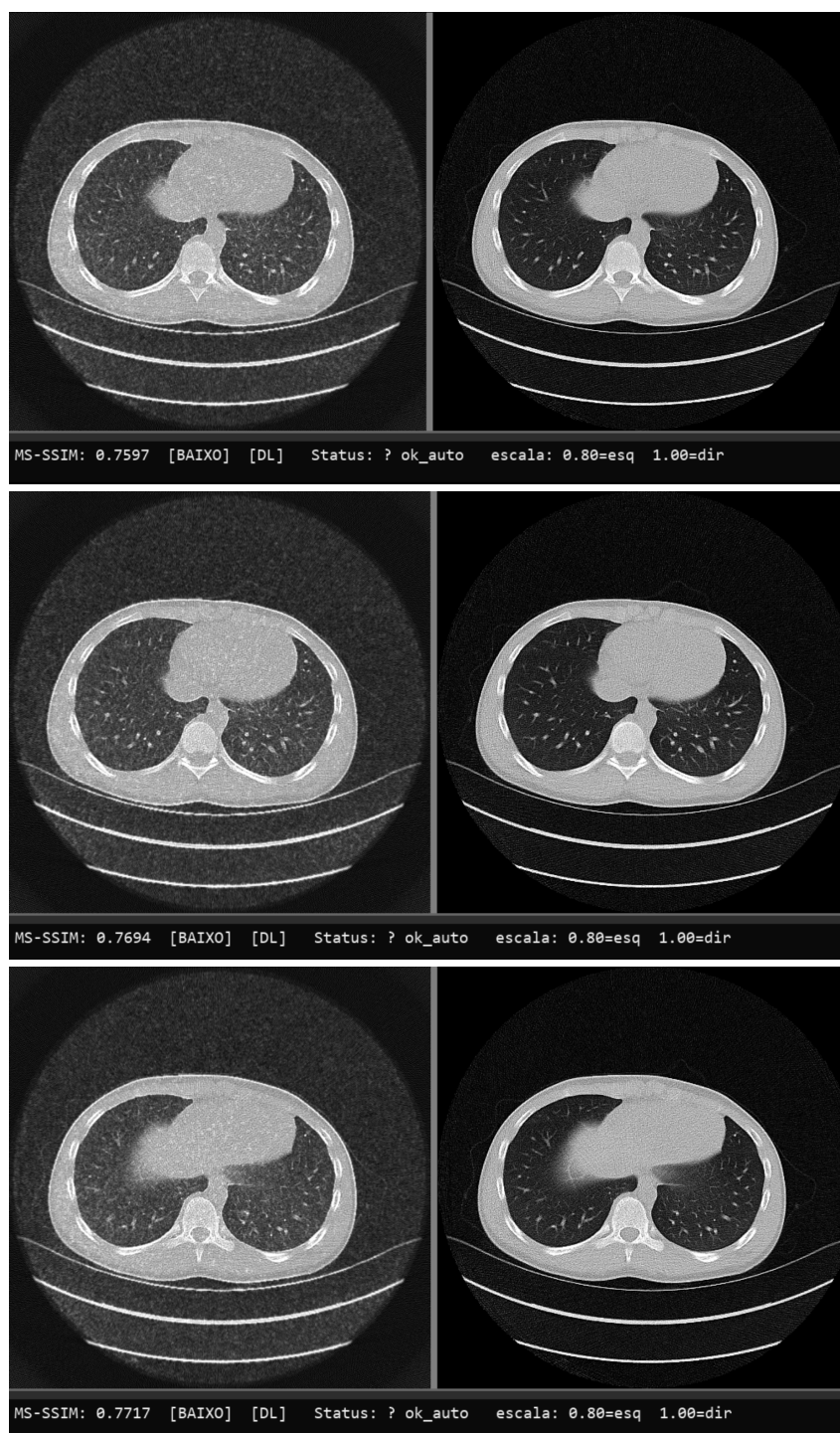


Fig.4.3 Exemplos de pares correspondentes com valores de **MS-SSIM** (0.7597, 0.7694 e 0.7717, respetivamente) aprovados após revisão visual humana mesmo com pontuações baixas.

Os pares reprovados apresentavam **MS-SSIM** claramente fora do padrão (< 0.61), com valores extremamente baixos, como podem ver na figura 4.4. Além disso, representaram os pares com pontuação mais próximas do limiar de aceitação automática de 0.994 4.5. Demonstrando que os casos em que o método falha são outliers claros em **MS-SSIM** e permanecem

justamente na zona cinzenta e propensa a erros da determinação empírica do limiar de aceitação automática. Além disso, os pares reprovados possuem características visuais bastante particulares com fundo dominando a imagem e poucas estruturas anatômicas visíveis, o que torna a avaliação de similaridade estrutural mais desafiadora devido a grande homogeneidade das características visuais.

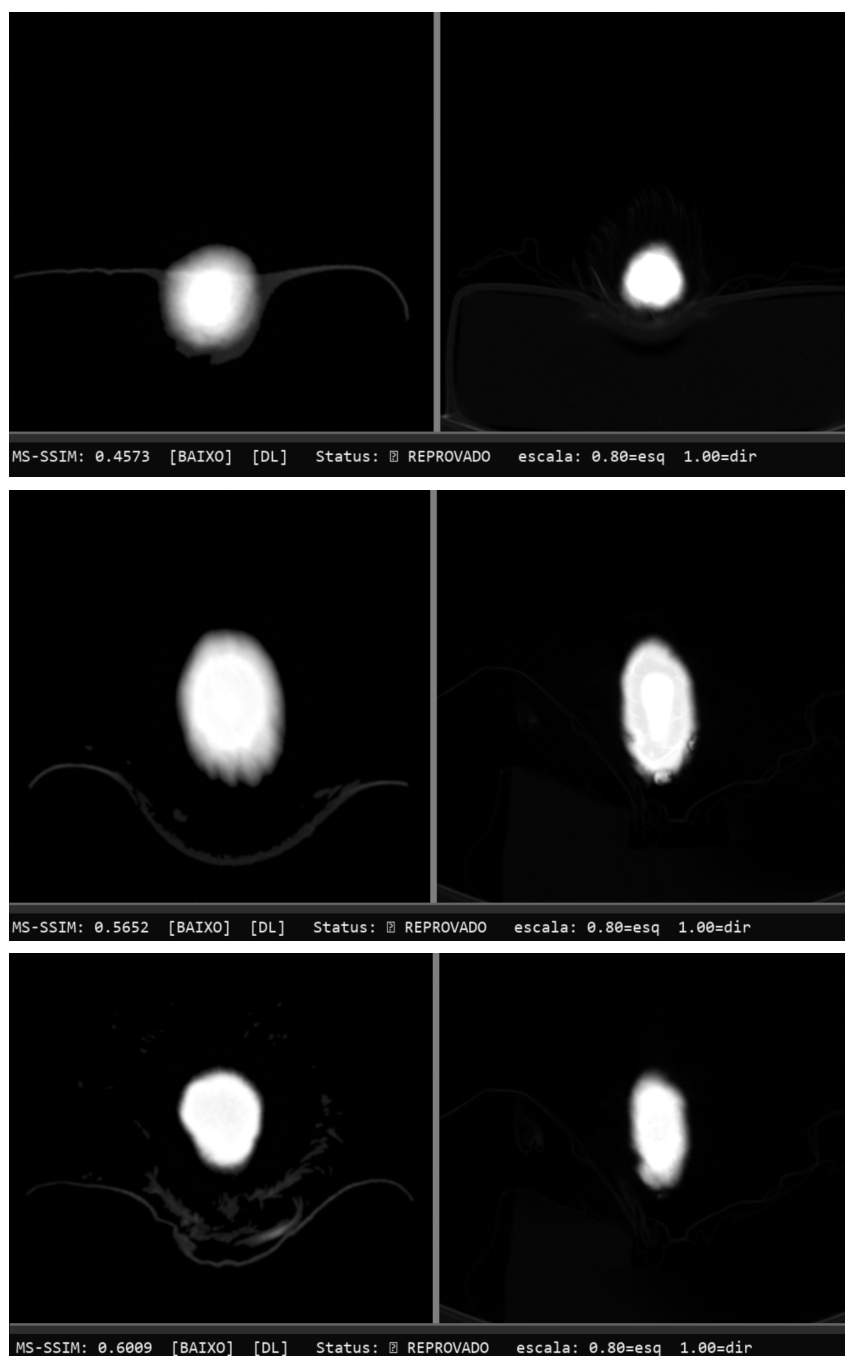


Fig.4.4 3 pares reprovados após inspeção visual humana com valores de [MS-SSIM](#) (head_1159: 0.4573, head_369: 0.5652 e head_763: 0.6009, respetivamente). As pontuações desses pares na similaridade de cosseno foram head_1159: 0.9960, head_369: 0.9952 e head_763: 0.9951.

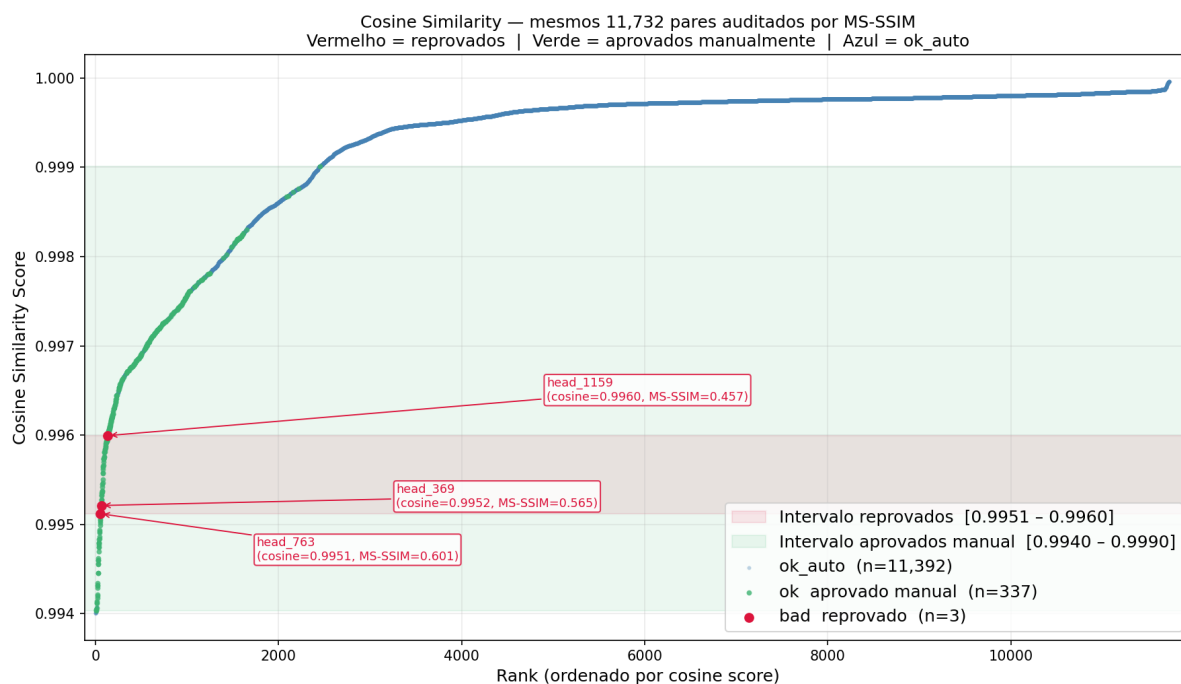


Fig.4.5 Distribuição dos valores de similaridade de cosseno para os pares inspecionados visualmente.

Os pares com **MS-SSIM** mais críticos logo acima dos reprovados tinham valores maiores que 0.75 4.3, demonstrando uma distancia clara entre os falsos positivos e os aprovados visualmente. Todos os pares inspecionados com pontuação acima desse valor de **MS-SSIM** passaram no teste de inspeção visual 4.6. Como os pares que não passaram por esse escrutínio tinham pontuação acima de 0.90 em **MS-SSIM**, é seguro assumir que os pares automaticamente aprovados com pontuação acima desse limiar são confiáveis.

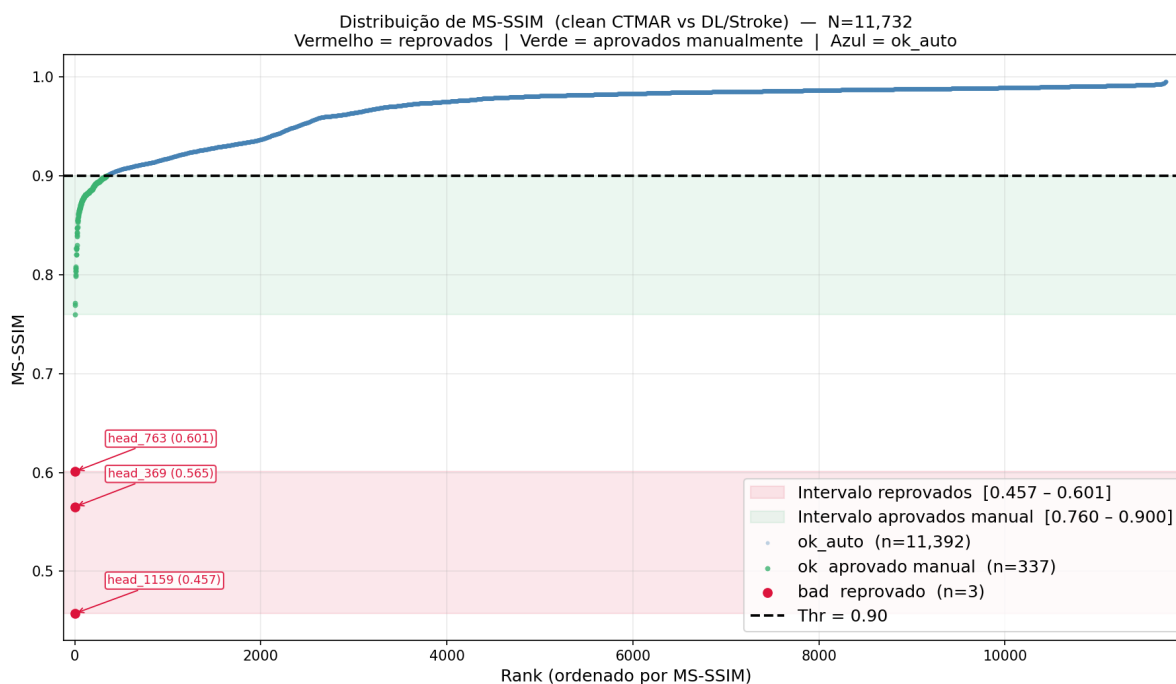


Fig.4.6 Distribuição dos valores de MS-SSIM para os pares inspecionados visualmente.

4.2 Ablação – Fase 1

4.2.1 Single-Head vs Dual-Head

O modelo baseline, baseado numa arquitetura U-Net dual-head sem módulos adicionais de atenção ou contexto multi-escala, foi utilizado como referência para todas as comparações subsequentes. Os resultados obtidos em validação e teste indicam desempenho consistente, sem sinais evidentes de sobreajuste, estabelecendo uma base estável para os estudos de ablation. A arquitetura atingiu os limiares de convergencia na epoch 7 e nessa mesma epoch obteve-se o melhor desempenho de MS-SSIM em validação, o que é consistente com a estratégia de treino curto adotada para esta fase.

As métricas quantitativas médias e suas distribuições encontram-se resumidas na Tabela 4.1.

Tabela 4.1 Métricas quantitativas do modelo baseline em validação e teste.

Conjunto	Δ PSNR (dB)	Δ MS-SSIM
Train	5.845	0.1525
Val	5.614	0.1474
Test	5.748	0.1537

De modo geral, observa-se equilíbrio entre preservação estrutural e redução de ruído, com desempenho semelhante entre os conjuntos de validação e teste.

Foi realizado um estudo para verificar qual o melhor peso de máscara para a função de perda. Foi testando os pesos 0.1, 0.05, e 0.01. A finalidade era observar qual os limites de atuação da segunda saída em regularização e preservação de detalhes. O modelo com peso 0.05 para a máscara apresentou melhor desempenho em validação, com ganhos marginais em **PSNR** e **SSIM**, sugerindo que a supervisão adicional contribui para uma correção mais equilibrada dos artefatos. O modelo com peso 0.1 apresentou resultados piores que o modelo *Single-Head*, demonstrado que a supervisão excessiva da máscara pode levar a degradação de detalhes ao competir com a tarefa de reconstrução. Dessa forma, o peso da função de perda da saída de máscara foi diminuído para 0.05. Para esse peso, os resultados melhoram para **MS-SSIM**, **SSIM**, **PSNR** e **Mean Absolute Error (MAE)** com relação ao peso 0.1, mas ainda apresentam uma leve degradação em relação ao modelo *Single-Head*. O valor do **DICE** teve uma leve queda, mas manteve-se acima de 0.70, o que é considerado um desempenho aceitável para a tarefa de segmentação de artefatos com finalidade de regularização. Para o peso 0.01, o desempenho melhora em relação ao modelo com peso 0.05, mais uma vez melhorando **MS-SSIM**, **SSIM**, **PSNR** e **MAE**, mas o valor do **Dice Similarity Coefficient (DICE)** tem uma queda mais acentuada, ficando abaixo de 0.70.

Tabela 4.2 Resultados do estudo de *trade-off* entre reconstrução e segmentação para diferentes pesos da máscara.

Configuração Métrica	Qualidade Reconstrução PSNR/MS-SSIM	Qualidade Segmentação DICE
Single-Head	5.614	0.1474
Dual-Head (w=0.1)	35.07/0.9853	0.7680
Dual-Head (w=0.05)	35.287/0.986	0.754
Dual-Head (w=0.01)	35.971/0.987	0.649

4.3 Ablação – Fase 2

4.3.1 Impacto dos Módulos de Atenção -

1. *Baseline* + **SE**

2. *Baseline* + ASPP

A introdução do módulo *Atrous Spatial Pyramid Pooling* (ASPP) no *bottleneck* da arquitetura resultou em melhorias consistentes nas métricas de similaridade estrutural. Em comparação com o modelo *baseline*, o modelo com ASPP apresentou aumento médio de SSIM tanto em validação quanto em teste, acompanhado por variações moderadas em PSNR. A análise das distribuições de desempenho mostra deslocamento positivo da mediana e redução da fração de amostras com degradação de desempenho, sugerindo benefício do contexto multi-escala capturado pelo ASPP. Estes resultados indicam que a incorporação de informação em múltiplas escalas contribui para uma correção mais estável dos artefatos.

3. *Baseline* + CBAM

4. *Baseline* + SE + ASPP + CBAM

4.4 Seleção do Modelo para Treino Intermédio

Com base nos critérios definidos — consistência entre validação e teste, análise distributiva, controlo de sobreajuste e significância estatística — foi selecionada a arquitetura candidata para a fase de treino intermédio (30 – 40 épocas).

A Tabela (model selection criteria) resume os critérios de decisão adotados neste trabalho, fornecendo transparência ao processo de seleção e evitando escolhas arbitrárias baseadas apenas em métricas médias.

4.5 Treino com Duração Intermediária

4.6 Treino com Duração Prolongada

4.7 Análise de Distribuições e Overfitting – Modelo Final

Para além das médias, foram analisadas as distribuições das métricas (P25, P50 e P75), bem como o *gap* entre treino, validação e teste. Modelos com bom desempenho apresentaram diferenças limitadas entre treino e validação, dentro dos limites definidos no protocolo experimental.

Arquiteturas que apresentaram melhorias apenas em treino, sem reflexo consistente em validação e teste, foram consideradas menos robustas e descartadas da fase seguinte.

4.8 Análise Estatística Pareada – Modelo Final

A significância estatística das melhorias observadas foi avaliada por meio de testes pareados de Wilcoxon aplicados às diferenças de PSNR e SSIM entre modelos. Para controlar o erro do tipo I associado a múltiplas comparações, foi aplicada a correção de Holm–Bonferroni.

Além do valor-p corrigido, foi utilizado o tamanho de efeito de Cliff's delta para avaliar a relevância prática das diferenças observadas. Apenas melhorias estatisticamente significativas e com tamanho de efeito não desprezível foram consideradas na seleção do modelo final.

4.9 Resumo dos Resultados

Os resultados apresentados neste capítulo demonstram que a incorporação progressiva de contexto multi-escala e mecanismos de atenção contribui para melhorias consistentes na redução de artefatos em CT. A análise detalhada evidencia a importância de critérios objetivos e avaliação estatística rigorosa para a seleção de arquiteturas robustas, estabelecendo bases sólidas para as fases subsequentes de treino prolongado e validação externa.

Capítulo 5

Discussion

Capítulo 6

Conclusion

Bibliografia

- [1] W.C. Röntgen. On a new kind of rays. *Journal of the Franklin Institute*, 141(3):183–191, 1896. [Cited on page 1.]
- [2] Emico Okuno and Elisabeth Yoshimura. *Física das Radiações*. Oficina de Textos, 2010. [Cited on page 1.]
- [3] November 8, 1895: Roentgen's Discovery of X-Rays. <https://www.aps.org/apsnews/2001/11/1895-roentgens-discovery-xrays>. [Cited on page 1.]
- [4] JOEL D. HOWELL. EARLY CLINICAL USE OF THE X-RAY. *Transactions of the American Clinical and Climatological Association*, 127:341–349, 2016. [Cited on page 2.]
- [5] Allen Taylor. Illuminating Health: The Evolution and Significance of X-ray Imaging. *Imaging in Medicine*, 15(6):133–134, December 2023. [Cited on page 2.]
- [6] Reza Vali. Unveiling the Marvels of Computed Tomography (CT) Imaging. *Imaging in Medicine*, 16(1):150–151, February 2024. [Cited on page 2.]
- [7] Mohd Noor. An Overview of Computed Tomography: What it is and How it Works? Applications of Computed Tomography. *Imaging in Medicine*, 15(5):93–94, October 2023. [Cited on page 2.]
- [8] Raymond A. Schulz, Jay A. Stein, and Norbert J. Pelc. How CT happened: The early development of medical computed tomography. *Journal of Medical Imaging*, 8(5):052110, September 2021. [Cited on page 2.]
- [9] F. Edward Boas and Dominik Fleischmann. CT artifacts: Causes and reduction techniques. *Imaging in Medicine*, 4(2):229–240, April 2012. [Cited on page 2.]

- [10] Cecile E.J. Kleber, Ramez Karius, Lucas E. Naessens, Coen O. Van Toledo, Jochen A. C. Van Osch, Martijn F. Boomsma, Jan W.T. Heemskerk, and Aart J. Van Der Molen. Advancements in supervised deep learning for metal artifact reduction in computed tomography: A systematic review. *European Journal of Radiology*, 181:111732, December 2024. [Cited on pages 2, 5, 6, and 16.]
- [11] Sathyathas Puvanasunthararajah, Davide Fontanarosa, Marie-Luise Wille, and Saskia M. Camps. The application of metal artifact reduction methods on computed tomography scans for radiotherapy applications: A literature review. *Journal of Applied Clinical Medical Physics*, 22(6):198–223, May 2021. [Cited on page 3.]
- [12] Asutosh Sahu, Shobhit Mathur, Hiroyuki Takaoka, Joji Ota, Felix G. Meinel, Benjamin Böttcher, Benoît Magnin, Ankush Jajodia, and Corey T. Jensen. Transforming CT imaging with deep learning: Noise reduction, artifact management, and clinical applications – A comprehensive review. *European Journal of Radiology Artificial Intelligence*, 4:100042, December 2025. [Cited on pages 3, 5, and 6.]
- [13] Mohanad Alkhodari, Eman Alefishat, Herbert F. Jelinek, Ahmed Kaabneh, and Panos Liat-sis. Enhancing CCTA image quality: A review of deep learning approaches for advanced artifact correction and denoising. *Artificial Intelligence Review*, 58(10):331, August 2025. [Cited on page 3.]
- [14] Julia F. Barrett and Nicholas Keat. Artifacts in CT: Recognition and Avoidance. *Radio-graphics*, 24(6):1679–1691, November 2004. [Cited on page 5.]
- [15] Mark Selles, Jochen A.C. Van Osch, Mario Maas, Martijn F. Boomsma, and Ruud H.H. Wellenberg. Advances in metal artifact reduction in CT images: A review of traditional and novel metal artifact reduction techniques. *European Journal of Radiology*, 170:111276, January 2024. [Cited on page 6.]
- [16] Lars Gjestebj, Qingsong Yang, Yan Xi, Bernhard E. H. Claus, Yannan Jin, Bruno De Man, Ge Wang, and Hongming Shan. Deep learning methods for CT image-domain metal artifact reduction. In Bert Müller and Ge Wang, editors, *Developments in X-Ray Tomography XI*, page 31, San Diego, United States, September 2017. SPIE. [Cited on pages 6 and 7.]
- [17] Yanbo Zhang and Hengyong Yu. Convolutional Neural Network Based Metal Artifact Reduction in X-Ray Computed Tomography. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 37(6):1370–1381, June 2018. [Cited on pages 6 and 7.]

- [18] Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, and Thomas Brox. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation, May 2015. [Cited on pages 6 and 18.]
- [19] Esther Meyer, Frank Bergner, Rainer Raupach, Thomas Flohr, and Marc Kachelriess. Normalized metal artifact reduction (NMAR) in computed tomography. In *2009 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC)*, pages 3251–3255, Orlando, FL, October 2009. IEEE. [Cited on page 7.]
- [20] Wei-An Lin, Haofu Liao, Cheng Peng, Xiaohang Sun, Jingdan Zhang, Jiebo Luo, Rama Chellappa, and Shaohua Kevin Zhou. DuDoNet: Dual Domain Network for CT Metal Artifact Reduction. In *2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 10504–10513, Long Beach, CA, USA, June 2019. IEEE. [Cited on pages 7 and 16.]
- [21] Lequan Yu, Zhicheng Zhang, Xiaomeng Li, Hongyi Ren, Wei Zhao, and Lei Xing. Metal Artifact Reduction in 2D CT Images with Self-supervised Cross-domain Learning. *Physics in Medicine & Biology*, 66(17):175003, September 2021. [Cited on page 7.]
- [22] Zhiwei Huang, Guo Zhang, Jinzhao Lin, Yu Pang, Huiqian Wang, Tong Bai, and Lisha Zhong. Multi-modal feature-fusion for CT metal artifact reduction using edge-enhanced generative adversarial networks. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 217:106700, April 2022. [Cited on page 7.]
- [23] Xin Yi, Ekta Walia, and Paul Babyn. Generative Adversarial Network in Medical Imaging: A Review. *Medical Image Analysis*, 58:101552, December 2019. [Cited on page 7.]
- [24] Jie Hu, Li Shen, and Gang Sun. Squeeze-and-Excitation Networks. In *2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 7132–7141, June 2018. [Cited on pages 7, 20, 21, 24, 26, 27, and 30.]
- [25] Sanghyun Woo, Jongchan Park, Joon-Young Lee, and In So Kweon. CBAM: Convolutional Block Attention Module. In Vittorio Ferrari, Martial Hebert, Cristian Sminchisescu, and Yair Weiss, editors, *Computer Vision – ECCV 2018*, volume 11211, pages 3–19. Springer International Publishing, Cham, 2018. [Cited on pages 7, 22, 30, 32, 33, and 35.]
- [26] Liang-Chieh Chen, George Papandreou, Florian Schroff, and Hartwig Adam. Rethinking Atrous Convolution for Semantic Image Segmentation, December 2017. [Cited on pages 8, 27, and 28.]

- [27] Zhou Wang, A.C. Bovik, H.R. Sheikh, and E.P. Simoncelli. Image quality assessment: From error visibility to structural similarity. *IEEE Transactions on Image Processing*, 13(4):600–612, April 2004. [Cited on pages 8, 13, 14, and 16.]
- [28] Z. Wang, E.P. Simoncelli, and A.C. Bovik. Multiscale structural similarity for image quality assessment. In *The Thrity-Seventh Asilomar Conference on Signals, Systems & Computers, 2003*, pages 1398–1402, Pacific Grove, CA, USA, 2003. IEEE. [Cited on pages 8 and 39.]
- [29] Alain Hore and Djemel Ziou. Image Quality Metrics: PSNR vs. SSIM. In *2010 20th International Conference on Pattern Recognition*, pages 2366–2369, Istanbul, Turkey, August 2010. IEEE. [Cited on page 8.]
- [30] John R. Zech, Marcus A. Badgeley, Manway Liu, Anthony B. Costa, Joseph J. Titano, and Eric Karl Oermann. Variable generalization performance of a deep learning model to detect pneumonia in chest radiographs: A cross-sectional study. *PLOS Medicine*, 15(11):e1002683, November 2018. [Cited on page 8.]
- [31] Martin J. Willemink, Wojciech A. Koszek, Cailin Hardell, Jie Wu, Dominik Fleischmann, Hugh Harvey, Les R. Folio, Ronald M. Summers, Daniel L. Rubin, and Matthew P. Lungren. Preparing Medical Imaging Data for Machine Learning. *Radiology*, 295(1):4–15, April 2020. [Cited on page 8.]
- [32] Christopher J. Kelly, Alan Karthikesalingam, Mustafa Suleyman, Greg Corrado, and Dominic King. Key challenges for delivering clinical impact with artificial intelligence. *BMC Medicine*, 17(1):195, December 2019. [Cited on page 8.]
- [33] Eri Haneda, Nils Peters, Jiayong Zhang, Grigorios Karageorgos, Wenjun Xia, Harald Paganetti, Ge Wang, Yi Guo, Jianhua Ma, Hyoung Suk Park, Kiwan Jeon, Fuxin Fan, Mareike Thies, and Bruno De Man. AAPM CT metal artifact reduction grand challenge. *Medical Physics*, 52(10):e70050, October 2025. [Cited on page 11.]
- [34] xcist. AAPM CT Metal Artifact Reduction (CT-MAR) Grand Challenge Benchmark Tool. https://github.com/xcist/example/tree/main/AAPM_datachallenge/. [Cited on page 11.]
- [35] Nils Peters, Eri Haneda, Jiayong Zhang, Grigorios Karageorgos, Wenjun Xia, Joost Verburg, Ge Wang, Harald Paganetti, and Bruno De Man. A hybrid training database and evaluation benchmark for assessing metal artifact reduction methods for X-ray CT imaging. *Medical Physics*, 52(10):e70020, October 2025. [Cited on page 11.]

- [36] Mingye Wu, Paul FitzGerald, Jiayong Zhang, W. Paul Segars, Hengyong Yu, Yongshun Xu, and Bruno De Man. XCIST – An Open Access X-ray/CT Simulation Toolkit. *Physics in medicine and biology*, 67(19):10.1088/1361–6560/ac9174, September 2022. [Cited on page 11.]
- [37] Nir Goren, James Avery, Thomas Dowrick, Eleanor Mackle, Anna Witkowska-Wrobel, David Werring, and David Holder. Multi-frequency electrical impedance tomography and neuroimaging data in stroke patients. *Scientific Data*, 5:180112, July 2018. [Cited on pages 11 and 13.]
- [38] Nir Goren, Thomas Dowrick, James Avery, and David Holder. UCLH Stroke EIT Dataset - Radiology Data, August 2017. [Cited on page 11.]
- [39] Ke Yan, Xiaosong Wang, Le Lu, and Ronald M. Summers. DeepLesion: Automated mining of large-scale lesion annotations and universal lesion detection with deep learning. *Journal of Medical Imaging*, 5(3):036501, July 2018. [Cited on pages 11 and 13.]
- [40] Mustafa Umit Oner, Yi-Chih Cheng, Hwee Kuan Lee, and Wing-Kin Sung. Training machine learning models on patient level data segregation is crucial in practical clinical applications, April 2020. [Cited on page 13.]
- [41] Jiang Hsieh. *Computed Tomography: Principles, Design, Artifacts, and Recent Advances*. Wiley Interscience ; SPIE Press, Hoboken, N.J. : Bellingham, Wash, 2nd ed edition, 2009. [Cited on pages 13 and 14.]
- [42] Yang Li, Bobo Yan, Jianxin Hou, Bingyang Bai, Xiaoyu Huang, Canfei Xu, and Limei Fang. UNet based on dynamic convolution decomposition and triplet attention. *Scientific Reports*, 14(1):271, January 2024. [Cited on page 18.]
- [43] Liang-Chieh Chen, Yukun Zhu, George Papandreou, Florian Schroff, and Hartwig Adam. Encoder-Decoder with Atrous Separable Convolution for Semantic Image Segmentation, August 2018. [Cited on pages 27, 28, and 29.]
- [44] Hang Zhao, Orazio Gallo, Iuri Frosio, and Jan Kautz. Loss Functions for Image Restoration With Neural Networks. *IEEE Transactions on Computational Imaging*, 3(1):47–57, March 2017. [Cited on pages 37 and 38.]
- [45] Fabian Isensee, Jens Petersen, Andre Klein, David Zimmerer, Paul F. Jaeger, Simon Kohl, Jakob Wasserthal, Gregor Koehler, Tobias Norajitra, Sebastian Wirkert, and Klaus H.

- Maier-Hein. nnU-Net: Self-adapting Framework for U-Net-Based Medical Image Segmentation. <https://arxiv.org/abs/1809.10486v1>, September 2018. [Cited on page 38.]
- [46] Saeid Asgari Taghanaki, Yefeng Zheng, S. Kevin Zhou, Bogdan Georgescu, Puneet Sharma, Daguang Xu, Dorin Comaniciu, and Ghassan Hamarneh. Combo Loss: Handling Input and Output Imbalance in Multi-Organ Segmentation, September 2021. [Cited on page 38.]
- [47] Lin Zhang, Lei Zhang, Xuanqin Mou, and D. Zhang. FSIM: A Feature Similarity Index for Image Quality Assessment. *IEEE Transactions on Image Processing*, 20(8):2378–2386, August 2011. [Cited on page 40.]

Apêndice A

Appendix Title Here

Write your Appendix content here.